TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Năm học: 2025 – 2026

PHIẾU ĐIỂM DANH

TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP

I. Thông Tin Cá Nhân

Họ và tên: HUỲNH HOÀNG TIẾN ĐẠT MSSV: 52200023

Ngành học:Kỹ thuật phần mềm Email: 52200023@student.tdtu.edu.vn SĐT: 0376303548

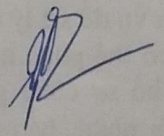
Doanh nghiệp thực tập: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ISOFH**

Địa chỉ: 35 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Văn phòng đại diện: Tầng 6, Tòa nhà Văn phòng Tổng công ty xây dựng Thủy Lợi 4, Số 286-288, Nguyễn Xí, P. 13, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Cán bộ hướng dẫn: NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH **Email/SĐT:** quynhnguyen229@gmail.com/0986065285

II. Bảng Điểm Danh

STT	Ngày làm việc & Thời gian	Nội dung công việc	Cán bộ hướng dẫn xác nhận	Nhận xét / Ghi chú
1	11/08/2025 (8:00 – 17:30)	Trong ngày làm việc, em đã xử lý nhiều tình huống phát sinh tại các khoa phòng. Đầu tiên là trường hợp bác sĩ kê hai thuốc COPEDINA 75 mg và CLEALINE 50 mg có tên gần giống. Sau khi kiểm tra mã thuốc trên HIS và kho Dược, em xác nhận hai thuốc là khác nhau và giữ nguyên đơn, đồng thời đề xuất Dược rà soát danh mục để tránh nhầm lẫn. Tiếp đó, em xử lý việc mã bệnh nhân CR250701945 bị trùng nhưng lại thuộc hai người khác nhau do tiếp đón nhập liệu chưa đầy đủ. Em đã kiểm tra lịch sử, hủy hồ sơ sai và tạo tiếp đón mới đúng cho bệnh nhân thật, đồng thời lưu ý thu ngân để tránh sai sót thanh toán; kinh nghiệm rút ra là cần kiểm		Tốt

Được quét bằng CamScanner

		tra kỹ CCCD, họ tên và ngày sinh trước khi lưu hồ sơ. Trường hợp tiếp theo là bệnh nhân từ Khu B sang Khu Khám II nhưng bị hệ thống chặn tiếp đón do chưa tất toán tại khu cũ. Em kiểm tra trạng thái tạm ứng, hướng dẫn bệnh nhân quay lại thu ngân xử lý rồi mới tiếp đón tại khu mới. Ngoài ra, tại phòng khám Tai mũi họng, người dùng chưa được phân quyền duyệt BHYT nội trú nên không thao tác được; em hướng dẫn gửi yêu cầu phân quyền và hỗ trợ tạm thời thông qua tài khoản có quyền. Em cũng trực tiếp hướng dẫn thao tác duyệt BHYT trong module nội trú, chỉ ra các bước dễ sai và đề nghị xây dựng tài liệu hướng dẫn ngắn gọn cho điều dưỡng. Cuối cùng, tại phòng X-quang, kỹ thuật viên không xoá được chỉ định do thiếu quyền hoặc chỉ định đã gửi sang PACS; em kiểm tra trạng thái, hướng dẫn liên hệ PACS/KHTH để thu hồi hoặc xóa đúng quy trình. Các tình huống trên giúp em rút ra kinh nghiệm quan trọng về việc kiểm tra mã thuốc, xác thực định danh bệnh nhân, lưu ý tài chính trước khi chuyển khu, quản lý phân quyền chặt chẽ và đảm bảo sự đồng bộ giữa HIS – PACS nhằm tránh lỗi phát sinh.		
2	13/08/2025 (8:00 – 17:30)	Trong ngày làm việc, em đã hỗ trợ xử lý nhiều vấn đề tại các khoa phòng. Trước hết, em hướng dẫn bác sĩ phòng Tổng quát III thao tác sao chép đơn thuốc từ lần khám cũ bằng cách truy xuất lịch sử bệnh án và sử dụng chức năng Sao chép, giúp bác sĩ thao tác nhanh và chính xác hơn. Tiếp theo, em tiếp nhận lỗi mất thông tin BHYT khi đổi đối tượng khám sang dịch vụ; hệ thống xóa toàn bộ dữ liệu BHYT khiến điều dưỡng phải duyệt lại từ đầu. Em tiếp đón lại theo dịch vụ để xử lý tạm thời và kiến nghị giữ dữ liệu BHYT ở dạng ẩn để có thể phục hồi. Bên cạnh đó, trường hợp trùng tên nhưng khác mã hồ sơ cũng gây nhầm lẫn khi tiếp đón; em kiểm tra định danh bệnh nhân, báo lỗi duplicate cho CNTT và đề xuất in tên phòng khám trên tờ hẹn để dễ nhận biết. Ở phòng khám khác, sai sót CCCD và địa chỉ sau khi bác sĩ đã kết luận buộc em phải xin huỷ kết luận, sửa lại thông tin và xác định người thao tác sai để nhắc nhở. Một trường hợp khác là bệnh nhân không lên danh sách siêu		

Được quét bằng CamScanner

		âm tổng quát do chưa thanh toán đủ phí; em phối hợp thu ngân để xử lý bổ sung. Tại Nội thần kinh, nhân viên y tế tìm sai mã hồ sơ nên không in được đơn thuốc cũ, em giải thích sự khác biệt giữa mã hồ sơ và mã NB, sau đó hướng dẫn tìm và in đúng đơn. Tương tự, khi cần in lại giấy khám bệnh vào viện, em hướng dẫn thao tác tại mục In giấy tờ. Ngoài ra, có lỗi nhân đôi số lượng thuốc khi in đơn; em kiểm tra và yêu cầu xoá phần dư. Với sự cố không hiển thị nút ký chữ ký số trên iPad, em cho bệnh nhân nhập viện không ký tạm thời và báo kỹ thuật viên kiểm tra phân quyền. Hệ thống cũng không cho in đơn trắng khi đã có đơn cũ; em giải thích quy định và báo kỹ thuật xác minh. Với trường hợp kê trùng dịch vụ huyết học – truyền máu, em kiểm tra với LIS và hướng dẫn xóa dịch vụ trùng. Một số trường hợp áp thẻ BHYT hoặc TekMedi không ra đủ chỉ định hay không hiện tên trong danh sách siêu âm đều xuất phát từ thiếu phí; em hướng dẫn đóng bổ sung và áp lại thẻ để hệ thống hiển thị đầy đủ. Các tình huống trên giúp em rút ra nhiều kinh nghiệm về thao tác, kiểm tra dữ liệu và phối hợp liên phòng.		

Được quét bằng CamScanner

Họ và tên sinh viên: HUỲNH HOÀNG TIẾN ĐẠT

MSSV: 52200023

STT	Ngày làm việc & Thời gian	Nội dung công việc	Cán bộ hướng dẫn xác nhận	Nhận xét / Ghi chú
3	14/08/2025 (8:00 – 17:30)	Trong ngày làm việc, em đã hỗ trợ xử lý một số sự cố tại các phòng khám. Tại PK2 Tai Mũi Họng, bệnh nhân được chỉ định hai dịch vụ nhưng khi áp thẻ TekMedi chỉ hiển thị một dịch vụ; sau khi kiểm tra tạm ứng và áp lại thẻ, hệ thống nhận đủ chỉ định. Từ đó rút kinh nghiệm cần kiểm tra tình trạng tạm ứng và đồng bộ trước khi xử lý sâu hơn. Tại KKB2, phòng Nội soi gặp tình trạng máy nội soi không kết nối với máy tính, em hướng dẫn liên hệ bộ phận RIS để kiểm tra kết nối đúng quy trình nhằm tránh rủi ro thiết bị. Ở PK2 Nội Tổng Quát 1 và 2, bác sĩ không thể ký điện tử do dữ liệu chưa đồng bộ với hệ thống chữ ký số; em tiến hành đồng bộ lại và chức năng hoạt động bình thường, đồng thời lưu ý kiểm tra đồng bộ trước khi báo lỗi. Một trường hợp khác là điều dưỡng không tìm thấy phiếu bàn giao chuyển khoa; em kiểm tra hệ thống và xác nhận phiếu chưa được tạo, sau đó liên hệ chị Linh Vương và anh Toàn để xác minh thông tin, rút kinh nghiệm cần kiểm tra quy trình trước khi kết luận lỗi hệ thống. Ngoài ra, nhân viên y tế không nhập được ngày cấp CCCD trong phiếu nghỉ hưởng BHXH; em hướng dẫn vào Quản lý tiếp đón → Sửa thông tin để bổ sung và in lại chứng từ, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nắm rõ đường dẫn thao tác nhanh. Ở PK Gamma Knife, một bệnh nhân BHYT muốn đổi sang khám dịch vụ tại PK2 Tim Mạch Can Thiệp; em nhờ bác sĩ xoá chỉ định BHYT cũ và kê lại dịch vụ mới với hình thức Tự trả để đồng bộ địa điểm và thanh toán, tránh phát sinh sai sót. Cuối cùng, tại PK2 Nội Tổng Quát 2, bác sĩ kê chỉ định sang phòng Ngoại Tiết Niệu nhưng chọn giá Thường thay vì Theo yêu cầu; em chỉnh lại hình thức thanh toán và giải thích để bác sĩ nắm rõ, đồng thời rút kinh nghiệm cần đưa bước kiểm tra loại hình thanh toán vào checklist trước khi lưu chỉ định. Các tình huống trên giúp em nâng cao kỹ năng kiểm tra, phối hợp và xử lý sự cố liên quan đến chỉ định, thanh toán và đồng bộ dữ liệu.		

Được quét bằng CamScanner

4	15/08/2025 (8:00 – 17:30)	Trong quá trình hỗ trợ vận hành tại Khu Khám bệnh II – Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 15/08/2025, em ghi nhận nhiều vấn đề tồn đọng liên quan đến hệ thống HIS/RIS cũng như quy trình thao tác của bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế. Các vấn đề này tuy đã được báo cáo nhiều lần nhưng vẫn chưa được khắc phục, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khám chữa bệnh. Tại Phòng khám Nội tổng quát 1, bác sĩ không thể xem lại các dịch vụ kỹ thuật đã kê do mạng chập chờn khiến dữ liệu tải không đầy đủ. Việc hướng dẫn bác sĩ chuyển sang tab Dịch vụ kỹ thuật và chọn lại ngày khám là giải pháp tình thế, cho thấy tốc độ mạng và cơ chế truy xuất dữ liệu cần được cải thiện. Tương tự, trường hợp lệch tiền thanh toán cũng xảy ra khi bệnh nhân chỉ đóng 6.000.000đ nhưng hệ thống vẫn hiển thị 7.647.000đ. Em phải đối chiếu thông tin giữa HIS và module thu ngân rồi yêu cầu bệnh nhân áp lại thẻ TekMedi để đồng bộ dữ liệu. Tại PK2 – Nội soi, em gặp tình trạng bệnh nhân xuất hiện trên RIS nhưng không hiển thị trên HIS do nhân viên chưa được cấp quyền, gây gián đoạn quy trình và tạo bức xúc cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, bệnh nhân BHYT muốn làm thêm dịch vụ tại khu dịch vụ nhưng thu ngân không nhận tiền vì hồ sơ BHYT chưa tất toán, buộc phải tách hồ sơ thủ công, vừa mất thời gian vừa dễ sai sót. Một số lỗi khác cũng phát sinh như không in đủ thông số xét nghiệm, giá dịch vụ hiển thị sai loại hình, mạng khu Tiếp đón chậm và máy TekMedi thường xuyên treo khiến bệnh nhân phải chờ đợi lâu. Tại nhà thuốc, việc đơn thuốc bị nhân đôi hoặc mất dữ liệu khi in lại cũng thể hiện sự thiếu ổn định của hệ thống. Ngoài ghi nhận các lỗi, em cũng tiếp nhận những đề xuất cải tiến từ bác sĩ và nhân viên y tế. Nhu cầu lớn nhất là đơn giản hóa giao diện kê thuốc vì giao diện hiện tại có quá nhiều trường không cần thiết, gây rối mắt và mất thời gian, nhất là với các bác sĩ lớn tuổi. Tiếp theo, việc phân tách rõ ràng luồng khám BHYT và dịch vụ không BHYT cũng rất cần thiết để tránh nhầm lẫn loại giá và giảm áp lực cho thu ngân. Tất cả các phản ánh và đề xuất này đều được ghi nhận trực tiếp từ thực tế hoạt động tại phòng khám và có sự xác nhận của đội ngũ Isofh đang công tác tại đây. Em rất mong các bộ phận liên quan xem xét và triển khai sớm để nâng cao chất lượng dịch vụ của bệnh viện.		Tốt

Được quét bằng CamScanner

5	18/08/2025 (6:00 – 17:30)	Trong quá trình hỗ trợ tại phòng khám, em ghi nhận nhiều tình huống phát sinh liên quan đến máy TekMedi, hệ thống HIS và thao tác của nhân viên y tế. Một số bệnh nhân khi áp thẻ tại máy TekMedi in phiếu chỉ định thì bị sai tên phòng hoặc không có số thứ tự, hoặc bị in lặp, tách thành nhiều phiếu khác nhau; em đã hướng dẫn người bệnh áp thẻ lại sau khi hệ thống cập nhật hoặc in từ mục "Lịch sử khám bệnh" để lấy đúng chỉ định. Có trường hợp người bệnh dùng thẻ cũ nên hệ thống hiển thị chỉ định của tháng trước, em đã đưa bệnh nhân đến quầy để đổi thẻ mới và in lại phiếu. Với bác sĩ, em gặp tình huống bộ chỉ định dịch vụ không đúng do đăng nhập nhầm tài khoản, em đã hướng dẫn thoát và đăng nhập lại đúng tài khoản cá nhân. Một số bệnh nhân đến nhận kết quả nhưng đi nhầm phòng, em đã kiểm tra tình trạng kết quả và hướng dẫn họ quay lại đúng phòng chuyên khoa. Ngoài ra, điều dưỡng có trường hợp không lưu được thông tin nghề nghiệp, địa chỉ do hồ sơ đã tất toán, em hỗ trợ liên hệ CNTT để chỉnh sửa. Có lỗi nghiêm trọng khi điều dưỡng nhập nhầm thông tin BHYT giữa hai bệnh nhân, em đã rà soát hồ sơ, sửa lại dữ liệu đúng để bệnh nhân nhận thuốc bình thường. Bác sĩ cũng gặp trường hợp in đơn thuốc không hiển thị ngày tái khám vì thiếu bước lưu, em đã hướng dẫn lại quy trình chuẩn. Khi bác sĩ cần xóa chẩn đoán nơi giới thiệu hoặc nhập thông tin nghỉ hưởng BHXH, em đã kiểm tra và hướng dẫn thao tác đúng theo hệ thống. Trong suốt thời gian hỗ trợ, khó khăn lớn nhất là lượng bệnh nhân rất đông trong khi số lượng nhân sự IS còn ít, nhiều vấn đề xảy ra cùng lúc nên em phải cố gắng xử lý nhanh và linh hoạt. Một số lỗi lặp đi lặp lại nhiều lần cũng gây ảnh hưởng đến quy trình khám chữa bệnh, vì vậy em rút kinh nghiệm ghi nhận lại từng trường hợp để báo cáo, cải thiện hướng dẫn và đề xuất điều chỉnh hệ thống, giúp công tác hỗ trợ được trôi chảy và hiệu quả hơn.		
6	19/08/2025 (8:00 – 17:30)	Trong ngày làm việc, em ghi nhận và xử lý nhiều vấn đề phát sinh liên quan đến TekMedi và hệ thống HIS. Trước hết, máy TekMedi in phiếu chỉ định bị sai tên phòng và thiếu số thứ tự khám, khiến người bệnh đi nhầm phòng. Em đã phối hợp kỹ thuật kiểm tra, cập nhật lại dữ liệu và hướng dẫn người bệnh áp thẻ lại để in đúng thông tin. Trường hợp người bệnh Diệp Văn Chánh thuộc diện BHYT 100% nhưng hệ thống vẫn yêu		

Được quét bằng CamScanner

		cầu đóng tiền, em kiểm tra và phát hiện nhân viên kê nhầm loại hình thanh toán, sau đó chỉnh lại để hệ thống tự điều chỉnh về 0 đồng. Tiếp theo, có bệnh nhân Hồ Thị Bé Sáu bị trùng mã hồ sơ, em đã liên hệ kỹ thuật TekMedi hỗ trợ gộp để tránh ảnh hưởng quyền lợi BHYT. Ngoài ra, bác sĩ gặp lỗi khi kê DVKT trước khi bệnh nhân vào khám do hệ thống chặn quyết toán BHYT; em báo ngay kỹ thuật để mở quyền kê DVKT và hướng dẫn bác sĩ thao tác. Tại PK Nội tổng quát A2, bác sĩ không tìm thấy kết quả khám cũ, em hỗ trợ tra cứu qua mục Hồ sơ bệnh án và đề nghị bổ sung nút truy cập nhanh. Có trường hợp NB đến lấy máu nhưng chưa được kê DVKT xét nghiệm, em hướng dẫn quay lại phòng khám để bổ sung chỉ định. Nhiều NB thắc mắc về app mobile xem kết quả online, em hỗ trợ cài đặt, cung cấp mã QR và hướng dẫn liên kết hồ sơ. Trong ngày cũng ghi nhận hai ca liên tiếp lỗi quyết toán BHYT khi bác sĩ kê DVKT; em báo kỹ thuật xử lý đồng bộ dữ liệu. Một NB yêu cầu hủy DVKT nội soi gây mê nhưng hệ thống không cho vì thuốc đã được cấp, em vào tủ trực xóa thuốc rồi hủy DVKT cho NB để hoàn tiền đúng quy định. Cuối cùng, tình trạng đơn thuốc không hiển thị ngày tái khám do bác sĩ chưa lưu mục "Đơn hẹn tái khám", em đã hướng dẫn thao tác đúng để hệ thống hiển thị đầy đủ. Tổng thể, em đã phối hợp kỹ thuật, hỗ trợ nhân viên và hướng dẫn người bệnh kịp thời, đảm bảo quy trình khám chữa bệnh diễn ra thuận lợi và hạn chế tối đa sự cố phát sinh.		
7	20/08/2025 (5:00 – 17:30)	Hôm nay, trong quá trình làm việc tại các phòng khám, em đã ghi nhận một số sự cố liên quan đến hệ thống và quy trình KCB. Máy TekMedi in phiếu chỉ định đôi khi bị sai tên phòng và không hiện số thứ tự, khiến người bệnh đi nhầm phòng, phải hỏi lại nhân viên, gây mất thời gian; nguyên nhân có thể do lỗi đồng bộ dữ liệu giữa HIS và TekMedi, hiện bộ phận kỹ thuật đã báo TekMedi kiểm tra, tạm thời nhân viên hướng dẫn người bệnh áp thẻ lại. Ngoài ra, một số bệnh nhân như Thái Thị Yến hay Đoàn Thế Tuyền có hai mã NB gây trùng hồ sơ, dẫn đến thông tin thanh toán và chỉ định dịch vụ không đồng nhất; em đã phối hợp kiểm tra bằng tài khoản nội bộ, áp thẻ thử để đảm bảo bệnh nhân được tiếp nhận đúng quy trình, đồng thời rút ra kinh nghiệm cần kiểm tra hồ sơ tồn đọng trước khi tiếp đón mới và phối hợp chặt với CNTT. Trong ca sáng, một bác sĩ		Tốt

Được quét bằng CamScanner

		phòng Nội tổng quát 1 không mở được lịch sử khám cũ do chưa thao tác đúng, em đã hướng dẫn mở mục "Lịch sử khám chữa bệnh" và tìm kiếm DVKT, giúp bác sĩ tra cứu chính xác. Một số thiết bị tại phòng Nội trú 4B3 chạy chậm, đặc biệt khi check request; em đã kiểm tra kết nối mạng, hiệu suất máy, đối chiếu quy trình thao tác, ghi nhận kết quả để báo bộ phận kỹ thuật. Ngoài ra, có trường hợp DVKT không xuất hiện khi áp thẻ, bác sĩ chưa nắm cách nhập viện cấp cứu, lỗi toa ra viện, sai chữ ký bác sĩ, lệch giá mổ, trùng dịch vụ, phân giường, trả thuốc… Em nhận thấy cần tăng cường kiểm tra định kỳ hệ thống, xây dựng hướng dẫn thao tác nhanh, hỗ trợ tại chỗ, và phối hợp chặt chẽ với CNTT để xử lý kịp thời, giảm rủi ro, tránh gây chậm trễ hoặc bức xúc cho bệnh nhân, đồng thời đảm bảo quy trình KCB vận hành suôn sẻ.		
8	21/08/2025 (7:00 – 17:30)	Em đã báo cáo tình hình ghi nhận một số sự cố liên quan đến hệ thống TekMedi và quy trình khám chữa bệnh trong ngày. Khi in phiếu chỉ định, máy TekMedi đôi khi bị sai tên phòng thực hiện và không hiện số thứ tự khám, gây khó khăn cho người bệnh, dẫn đến đi nhầm phòng hoặc phải hỏi nhân viên y tế nhiều lần. Nguyên nhân có thể do dữ liệu chưa đồng bộ giữa HIS và TekMedi. Bộ phận kỹ thuật đã báo TekMedi kiểm tra và hướng dẫn người bệnh in lại phiếu, phiếu sau đó hiển thị đúng thông tin. Ngoài ra, bác sĩ tại phòng khám B gặp tình trạng máy chậm khi "check request", ảnh hưởng trực tiếp tới thời gian khám. Nguyên nhân có thể do cấu hình máy, mạng yếu hoặc phần mềm/server quá tải; hiện đã kiểm tra mạng, hiệu suất máy và quy trình thao tác để xác định nguyên nhân. Một số vấn đề khác gồm: bác sĩ thay đổi dịch vụ cho bệnh nhân nhưng chưa đổi phòng, dẫn đến bệnh nhân không hiển thị đúng; bác sĩ muốn xem kết quả xét nghiệm tổng thể của nhiều dịch vụ nhưng thao tác hiện tại rườm rà; một số bệnh nhân không có tên trong danh sách phòng khám do lỗi hủy tiếp đón hoặc dùng thẻ cũ; lịch hẹn tái khám không hiển thị trên đơn thuốc do bác sĩ chưa lưu đúng quy trình; bệnh nhân phải di chuyển nhiều lần do thông tin không đồng bộ giữa các phòng; điều dưỡng không thể chỉnh sửa thông tin hành chính khi sáp nhập hồ sơ. Kinh nghiệm rút ra là cần tuân thủ nghiêm quy trình tiếp đón, lưu dữ liệu, đồng bộ thông tin và hướng dẫn bác sĩ sử dụng đầy đủ các tính năng		

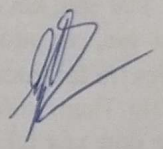
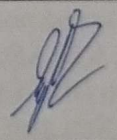
Được quét bằng CamScanner

		trên phần mềm. Ngoài ra, cần xây dựng kịch bản tạm thời hỗ trợ bệnh nhân khi phiếu in sai, kiểm tra định kỳ hệ thống TekMedi, phân loại sự cố theo máy, mạng và phần mềm, đồng thời tăng cường đào tạo nhân viên y tế về thao tác chuẩn và xử lý tình huống. Khó khăn hiện tại là số lượng bệnh nhân đông, nhân viên hỗ trợ hạn chế, dẫn đến việc xử lý các lỗi lặp đi lặp lại chưa kịp thời, làm trì trệ quy trình khám chữa bệnh và dễ gây ùn tắc tại các khu khám. Toàn bộ các sự cố và đề xuất khắc phục đều được em ghi nhận, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đồng bộ dữ liệu, tuân thủ quy trình và tăng cường hỗ trợ kỹ thuật để đảm bảo hiệu quả KCB.		
9	22/08/2025 (7:00 – 17:30)	Trong quá trình công tác tại phòng khám, em gặp nhiều vấn đề liên quan đến hệ thống HIS và quy trình khám chữa bệnh. Thứ nhất, việc kê dịch vụ kỹ thuật cho bệnh nhân tại khu B thường gặp lỗi do trùng lặp chỉ định, khiến bác sĩ không thể lưu lệnh, gây chậm trễ. Nguyên nhân là bệnh nhân có lịch khám nhiều phòng, nhân viên chưa rà soát dịch vụ đã kê trước đó. Bộ phận CNTT đã hỗ trợ kiểm tra và hướng dẫn xóa hoặc chỉnh sửa chỉ định. Thứ hai, việc duyệt BHYT đôi khi nhầm do cầm nhầm CCCD của bệnh nhân khác, dẫn đến thông tin BHYT bị nhập sai. Nguyên nhân xuất phát từ thao tác vội vàng, áp lực bệnh nhân đông. Hướng xử lý là đối chiếu thông tin và nhập lại đúng, đồng thời nhắc nhở nhân viên kiểm tra kỹ. Thứ ba, bác sĩ kê sai chẩn đoán hoặc nhập nhầm mã bệnh khi chuyển viện, hồ sơ bị hệ thống từ chối, ảnh hưởng quyền lợi BHYT. Hướng xử lý là hủy kết luận cũ, nhập lại đúng chẩn đoán và in giấy chuyển viện hợp lệ. Thứ tư, một số bệnh nhân được duyệt sai tỷ lệ BHYT do bỏ sót bước đo sinh hiệu hoặc dữ liệu HIS chưa đầy đủ, gây tạm ứng chi phí cao. Thứ năm, các vấn đề về tất toán hóa đơn, thanh toán vào hồ sơ cũ, in giấy hẹn tái khám hoặc in đơn thuốc trùng cũng gây phiền hà cho bác sĩ và người bệnh. Nguyên nhân chủ yếu là thao tác chưa chuẩn, HIS chưa tối ưu cảnh báo và quản lý dữ liệu. Qua những sự cố này, em rút ra kinh nghiệm cần kiểm tra kỹ thông tin bệnh nhân, rà soát dịch vụ và chẩn đoán trước khi lưu, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, đồng thời đề xuất cải tiến HIS để giảm thao tác dư thừa, cảnh báo sớm khi có lỗi và nâng cao trải nghiệm khám chữa bệnh. Ngoài ra, áp lực bệnh nhân đông		Tốt

Được quét bằng CamScanner

		khiến việc xử lý lỗi gặp khó khăn, nhiều sự cố lặp lại làm gián đoạn quy trình khám. Em nhận thấy cần cải thiện phối hợp giữa nhân viên y tế – CNTT – tiếp đón để đảm bảo quy trình thông suốt, giảm nhầm lẫn và rút ngắn thời gian chờ cho bệnh nhân.		
10	25/08/2025 (5:00 – 17:30)	Trong quá trình hỗ trợ tại Khu khám B và D, em đã gặp và xử lý nhiều tình huống phát sinh liên quan đến hệ thống HIS. Ở Khu B, em phát hiện một số bệnh nhân có trùng hoặc sai mã NB, dẫn đến xung đột hồ sơ và gián đoạn khám chữa bệnh. Em đã phối hợp với bác sĩ để xác định mã đúng, hủy dịch vụ ở hồ sơ sai và kê lại dịch vụ chính xác, đồng thời rút ra kinh nghiệm cần kiểm tra kỹ thông tin ngay tại quầy tiếp đón, tránh tạo trùng lặp và cập nhật HIS cảnh báo khi nhập dữ liệu trùng. Một số bệnh nhân đến lượt khám nhưng không hiển thị thông tin trên hệ thống, nguyên nhân do chưa đồng bộ danh mục HIS; em đã hướng dẫn đồng bộ và giải thích quy trình cho bác sĩ, giúp hệ thống hoạt động trở lại bình thường. Em cũng phát hiện một số hồ sơ bị sai tên, dịch vụ lưu nhầm hoặc thiếu, bác sĩ không thể chuyển bệnh nhân giữa các phòng, hoặc máy tính treo không load được HIS; em đã trực tiếp hướng dẫn chỉnh sửa hồ sơ, hủy dịch vụ sai, thanh toán đầy đủ để mở dịch vụ còn thiếu, cũng như phối hợp phòng CNTT xử lý máy treo, giúp quy trình khám không bị gián đoạn. Trong nhiều trường hợp, bệnh nhân bị chặn khi tiếp đón, quét thẻ BHYT không đầy đủ hoặc nhập nhầm hồ sơ do trùng tên; em đã kiểm tra, hướng dẫn đồng bộ dữ liệu, sử dụng CCCD thay thẻ BHYT và tạo mã NB mới để đảm bảo hồ sơ chính xác, tránh mất dữ liệu khám đã nhập. Ở Khu D, em xử lý tình huống bệnh nhân không xin được giấy nghỉ BHXH do nhầm hồ sơ và ngày tiếp đón, đồng thời hướng dẫn quay lại khu đúng để trả thuốc khi quét phiếu bị lỗi. Qua các sự cố này, em rút ra kinh nghiệm rằng nhân viên y tế và bác sĩ cần nắm chắc quy trình HIS, kiểm tra thông tin cá nhân và dịch vụ trước khi xác nhận, và HIS cần có cảnh báo trùng dữ liệu, chức năng đồng bộ, cũng như giao diện trực quan hơn để hỗ trợ công việc. Dù số lượng bệnh nhân đông và nhân lực hạn chế, em luôn cố gắng xử lý triệt để từng lỗi để đảm bảo quy trình khám chữa bệnh diễn ra liên tục và chính xác.		

Được quét bằng CamScanner

11	26/08/2025 (7:30 – 17:30)	Trong quá trình hỗ trợ tại nhiều vị trí khác nhau, em đã ghi nhận và xử lý một số vấn đề hệ thống TekMedi và HIS gặp phải ảnh hưởng đến quy trình khám chữa bệnh. Trước hết, hệ thống TekMedi từng bị lỗi khi in phiếu chỉ định dịch vụ kỹ thuật: trước ngày 26/08, phiếu in không hiển thị dịch vụ nội soi; sau khi sửa, chỉ còn nội soi hiển thị, các chỉ định khác biến mất. Em kiểm tra dữ liệu gốc trên HIS vẫn đầy đủ, hướng dẫn nhân viên y tế và bệnh nhân in phiếu từ mục Lịch sử khám chữa bệnh để đảm bảo thông tin không bị bỏ sót, đồng thời báo bộ phận kỹ thuật TekMedi để kiểm tra sâu hơn. Trường hợp người bệnh Trương Thị Thùy có hai mã NB và hai hồ sơ, em hướng dẫn bác sĩ xóa dịch vụ trên hồ sơ không hợp lệ, lưu ý nhân viên tiếp đón tra cứu bằng CCCD hoặc mã NB, tránh trùng lặp. Em cũng hỗ trợ bác sĩ in giấy chuyển viện khi hồ sơ đã đóng bằng cách mở lại hồ sơ, giúp in thành công. Với người bệnh Lê Hoàng Thanh, em phát hiện chỉ định sai phòng khám và hướng dẫn hủy dịch vụ sai để bệnh nhân không bị điều chuyển nhầm. Trường hợp NB Đoàn Thế Tuyền không thể xuất viện, em kiểm tra hồ sơ ngoại trú còn mở và hướng dẫn bác sĩ nhập kết luận để hoàn tất thủ tục. Một số bác sĩ chưa rõ thao tác xem chỉ định CLS hoặc đóng hồ sơ, em trực tiếp hướng dẫn mở danh sách hoặc nhập đầy đủ thông tin bắt buộc. Ngoài ra, em chỉnh sửa thông tin hành chính sai sót trên giấy hẹn tái khám, hướng dẫn in lại chính xác. Trong quá trình hỗ trợ, em nhận thấy các khó khăn như bệnh nhân đông, số lượng nhân viên hỗ trợ hạn chế, nhiều lỗi lặp lại gây trì trệ quy trình, và việc khắc phục các lỗi cơ bản thường xảy ra muộn so với thời điểm bệnh nhân vào khám. Từ các tình huống trên, em rút ra kinh nghiệm: luôn kiểm tra chéo dữ liệu gốc trước khi kết luận mất thông tin, áp dụng giải pháp tạm thời để không gián đoạn khám chữa bệnh, hướng dẫn trực tiếp cho nhân viên và bác sĩ, và đề xuất cơ chế cảnh báo, kiểm tra hồi quy sau mỗi lần chỉnh sửa hệ thống nhằm đảm bảo hoạt động KCB liên tục, chính xác và an toàn cho bệnh nhân.		Tốt
12	27/08/2025 (7:30 – 17:30)	Hôm nay trong quá trình hỗ trợ hệ thống HIS tại các phòng khám, em ghi nhận một số vấn đề nổi bật. Thứ nhất, tại khu khám E (Hóa xạ trị), khi trả thuốc cho người bệnh đến sớm, hệ thống hiển thị nhầm toa thuốc của khu B, khiến nhân viên y tế không thể hoàn trả trực tiếp; em đã dùng tài		Tốt

Được quét bằng CamScanner

		khoản nội bộ kiểm tra, hướng dẫn nhờ đồng nghiệp thao tác tạm thời và đồng bộ dữ liệu để khắc phục. Thứ hai, tại phòng khám Hậu môn – Trực tràng, bác sĩ không thể kê thêm dịch vụ kỹ thuật do hồ sơ BHYT đã quyết toán; em đã kiểm tra, chụp lỗi báo cáo cho kỹ thuật và hướng dẫn cách tạm thời tách bạch hồ sơ để không bỏ sót điều trị. Thứ ba, sau bản cập nhật ngày 27/08/2025, mục Hỏi bệnh bị mất các bộ mẫu cũ; em đã xác nhận lỗi chung, báo kỹ thuật và hướng dẫn bác sĩ nhập thủ công tạm thời. Thứ tư, một người bệnh không thể tất toán để nhập viện do xung đột thời hạn BHYT giữa hai hồ sơ; em đã hướng dẫn hủy duyệt BHYT cũ và duyệt lại đúng hạn, hồ sơ được tất toán thành công. Thứ năm, tại phòng khám B, máy tính bác sĩ chậm khi thực hiện "check request"; em đã kiểm tra mạng, cấu hình máy và quy trình thao tác, ghi nhận kết quả để báo kỹ thuật. Thứ sáu, khi cấp giấy nghỉ hưởng BHXH, nhân viên y tế chưa nắm rõ thao tác; em hướng dẫn kiểm tra hồ sơ, điền đầy đủ thông tin, in giấy và kiểm tra lại trước khi giao cho người bệnh. Thứ bảy, trường hợp NB Lâm Thị Thắm không in được toa thuốc do hồ sơ cũ chưa tất toán; em hướng dẫn xóa hồ sơ thừa, thanh toán số tiền còn thiếu và in toa thành công. Ngoài ra, em cũng tiếp nhận các yêu cầu sửa lỗi về tự động in hai tờ đơn thuốc và popup in giấy hẹn không cần thiết. Khó khăn gặp phải là lượng bệnh nhân đông, số lượng IS hỗ trợ hạn chế, các lỗi lặp lại khiến hệ thống và quy trình KCB trì trệ, đặc biệt buổi sáng khi bệnh nhân đến sớm, việc xử lý nhiều case cùng lúc còn chậm.		
13	28/08/2025 (7:00 – 17:30)	Hôm nay em trực tại phòng khám, gặp nhiều tình huống cần xử lý. Về toa thuốc, NB Lý Thị Mỹ An không in được vì hồ sơ khám chưa đóng; em đã kiểm tra trạng thái hồ sơ, liên hệ bác sĩ để hoàn thiện kết luận, đóng hồ sơ và hướng dẫn dược sĩ refresh danh sách chờ để in toa, theo dõi 5–10 phút đảm bảo NB nhận thuốc không gián đoạn. NB tái khám Cao Thị Rằng đi thẳng phòng khám, không có trong danh sách; em phối hợp CNTT và NVYT để thực hiện tiếp đón bổ sung, đưa NB vào hàng chờ, nhắc nhở treo biển hướng dẫn tái khám phải bốc số. Trường hợp NB Bùi Thị Kim Mỹ cần kê thêm dịch vụ sau khi BHYT đã quyết toán, em phối hợp BHYT nội bộ gỡ quyết toán, cho phép NVYT bổ sung DV, ghi lại mốc thời gian và ảnh màn hình để truy vết. NB Võ Thành Anh gặp lỗi		

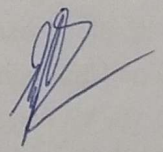
Được quét bằng CamScanner

		không mở hồ sơ mới do nợ viện phí cũ, em giải thích cơ chế, hướng dẫn NB thanh toán, xác nhận công nợ sạch để mở hồ sơ mới. NB Nguyễn Minh Khai vướng DVKT chưa thực hiện trong hồ sơ cũ đã quyết toán BHYT; em kiểm tra, gửi BHYT hủy quyết toán, NVYT hủy DVKT cũ và mở hồ sơ mới cho NB. Tại PK Ghép thận, em tìm NB đã đo ở PK khác bằng bộ lọc trạng thái, hướng dẫn NVYT chuyển tab để kế thừa kết quả, tránh tạo đo trùng. PK Nam khoa gặp sự cố đăng nhập nhiều tài khoản HIS; em hướng dẫn mở tab Ẩn danh hoặc dùng trình duyệt khác, báo IT để nâng cấp RAM. NB Trần Thị Nhờ chồng chéo hồ sơ khi chuyển PK; em rà soát hồ sơ, hủy tiếp đón/mã mới, kích hoạt hồ sơ cũ, xác nhận dòng tiền hoàn–thu. Ngoài ra, em phối hợp khắc phục lỗi tự động in hai tờ trong đơn thuốc, tinh giản popup giấy hẹn khi tái khám. Khó khăn: số lượng NB đông, IS hỗ trợ ít, nhiều lỗi lặp lại khiến quy trình KCB bị trì trệ, đặc biệt buổi sáng lượng bệnh nhân quá đông, một vài lỗi chưa xử lý kịp. Qua hôm nay, em rút ra kinh nghiệm: luôn kiểm tra trạng thái hồ sơ, đồng bộ dữ liệu, phối hợp nhanh với bác sĩ, NVYT, BHYT và tài chính để đảm bảo NB nhận dịch vụ liên tục, đồng thời nhắc nhở các bộ phận tuân thủ quy trình, tránh chồng chéo và ùn tắc.		
14	29/08/2025 (7:00 – 17:30)	Hôm nay, em đã xử lý nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh tại các phòng khám. Tại Phòng khám Nội tổng quát, em hỗ trợ bác sĩ thiết lập lại Bộ chỉ định dịch vụ CLS, kiểm tra và đồng bộ dữ liệu, hướng dẫn thao tác tránh lỗi do sử dụng nút Back trên trình duyệt, giúp bác sĩ sử dụng trọn vẹn bộ chỉ định. Với lỗi số thứ tự ưu tiên trên TekMedi, em phối hợp với bộ phận kỹ thuật và trấn an người bệnh để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe bệnh nhân. Tại Phòng khám Viêm gan, em phát hiện người bệnh Võ Thanh Sơn có sai ngày sinh trên hệ thống, dẫn đến không duyệt được BHYT, hướng dẫn sửa thông tin và cảnh báo về 2 mã NB để tránh lỗi gộp hồ sơ sau này. Với các trường hợp nhân đôi chỉ định CLS hay trùng mã hồ sơ, em phối hợp bác sĩ và các khoa kỹ thuật xử lý để đảm bảo dữ liệu chính xác, đồng thời hướng dẫn bệnh nhân hoàn tất thủ tục hủy khám hoặc hủy dịch vụ khi có yêu cầu, như trường hợp Nguyễn Ngọc Tâm Như và Hán Minh Tuấn. Em cũng hướng dẫn bệnh nhân khi có nhiều mã hồ sơ hoặc thiếu tiền, để áp thẻ TekMedi		

Được quét bằng CamScanner

		nhận số thứ tự khám, nhận thuốc hoặc chỉ định CLS đúng quy trình. Ngoài ra, em kiểm tra và hướng dẫn sửa lỗi ngày giờ chụp CT tại Phòng khám Tai mũi họng, xóa thuốc trùng tại Nội thận, đồng thời hỗ trợ các thao tác trên phần mềm HIS để cải thiện tốc độ và độ chính xác, như việc "check request" chậm do máy cấu hình yếu. Trong quá trình hỗ trợ, em rút ra kinh nghiệm cần phối hợp chặt chẽ với các bác sĩ, nhân viên y tế và bộ phận kỹ thuật, hướng dẫn bệnh nhân rõ ràng, đồng thời kiến nghị cải tiến hệ thống TekMedi và HIS để tránh lỗi lặp lại, giảm thời gian chờ đợi và nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh. Em nhận thấy khó khăn lớn là số lượng bệnh nhân đông, nhân lực hỗ trợ ít, nhiều lỗi lặp lại và thiết bị của bác sĩ chưa đáp ứng tốt, nhưng em đã cố gắng xử lý kịp thời và hỗ trợ tối đa để đảm bảo quá trình khám bệnh diễn ra thông suốt.		
15	03/09/2025 (5:00 – 17:30)	Hôm nay, em ghi nhận một số vấn đề tại khu Khám bệnh II và trong quá trình học nghiệp vụ Business Analyst. Về tiếp đón, có 3 ca người bệnh bị hệ thống chặn do hồ sơ khám trước đó tại Khám bệnh B chưa được tất toán, em đã hướng dẫn họ quay lại quầy Thu ngân để thanh toán và mở tiếp quyền tiếp đón, nhắc nhở cần đảm bảo tất toán hồ sơ cũ. Một số người bệnh không thể quét đơn thuốc để lấy số thứ tự, em kiểm tra thấy hồ sơ vẫn có trên hệ thống nhưng đã được tiếp đón trước đó, nên em in giấy khám trực tiếp để họ tiếp tục quy trình. Ngoài ra, em hướng dẫn nhân viên y tế thiết lập giao diện tiếp đón, điều chỉnh hiển thị các loại hình khám và thống kê người bệnh, giúp thao tác dễ dàng hơn, đồng thời hỗ trợ nhân viên mới làm quen với quy trình, xử lý các tình huống phát sinh như NB chưa thanh toán hay thay đổi dịch vụ, nhờ đó giảm tình trạng ùn ứ. Trong quá trình training BA, em học lại quy trình Quản lý Kho, bao gồm quản lý thầu với các bước tạo, sửa, gửi duyệt và đối chiếu hồ sơ, quy trình nhập kho – gửi duyệt, duyệt hoặc từ chối phiếu nhập, quy trình xuất kho – gửi duyệt, duyệt hoặc từ chối phiếu xuất, quy trình lĩnh nội trú/lĩnh bù và trả hàng hóa cho NB với các trạng thái xử lý rõ ràng. Em cũng tham gia khắc phục các lỗi hệ thống, bao gồm việc in đơn thuốc trùng, popup hẹn tái khám thừa thao tác, hiển thị phòng khám lần trước, thao tác chuẩn đoán và kê thuốc nhanh hơn để hỗ trợ bác sĩ và NB. Khó khăn em gặp phải gồm lượng bệnh nhân đông, số lượng nhân viên		

Được quét bằng CamScanner

		hỗ trợ ít, các lỗi lặp đi lặp lại, máy tính cấu hình thấp khiến quá trình KCB bị trì trệ, nhiều thao tác trong hệ thống chưa tối ưu, dẫn đến NB phải chờ lâu. Qua hôm nay, em rút ra kinh nghiệm cần theo dõi sát lỗi hệ thống, hướng dẫn nhân viên y tế, đồng thời cải thiện thao tác để quy trình khám chữa bệnh diễn ra trơn tru, hiệu quả hơn.		
16	04/09/2025 (8:00 – 17:30)	Trong ngày hôm nay, em tập trung thực hiện các công việc liên quan đến vai trò của một Business Analyst, chủ yếu xoay quanh việc thu thập, phân tích và làm rõ các yêu cầu của người dùng để hỗ trợ đội ngũ phát triển. Ngay từ buổi sáng, em tiến hành rà soát lại quy trình xử lý yêu cầu hỗ trợ hiện tại, qua đó nhận thấy hệ thống chưa có các trường dữ liệu quan trọng như *"Ghi chú"*, *"Phân loại"* và *"Trạng thái"*. Điều này dẫn đến nhiều khó khăn trong việc thống kê, theo dõi tiến độ cũng như phân loại bản chất của từng yêu cầu, khiến quá trình quản lý và xử lý thiếu tính minh bạch và chưa tối ưu. Từ việc phân tích thực trạng, em ghi nhận rõ ràng vấn đề để chuẩn bị đề xuất các giải pháp phù hợp. Sau khi đã tổng hợp và phân tích, em chủ động làm việc với các bộ phận liên quan để thảo luận về phạm vi phân quyền hiển thị. Trong quá trình trao đổi, em làm rõ nhu cầu cụ thể của từng cấp người dùng: tài khoản cá nhân cần được giới hạn trong phạm vi các yêu cầu do chính mình tạo; trưởng khoa hoặc quản lý khoa cần khả năng xem toàn bộ yêu cầu trong phạm vi khoa; và quản trị viên hoặc những người có phân quyền cao hơn cần quyền xem toàn bộ danh sách yêu cầu trên toàn cơ sở y tế. Việc phân quyền này không chỉ đảm bảo tính minh bạch, công bằng mà còn nâng cao hiệu quả quản lý và kiểm soát tiến độ xử lý yêu cầu. Bên cạnh đó, em thực hiện chỉnh sửa và bổ sung giao diện trên Figma để mô phỏng trực quan các thay đổi. Em thêm các trường mới vào màn hình yêu cầu hỗ trợ, đồng thời sắp xếp lại bố cục sao cho hợp lý, trực quan và dễ thao tác. Đây là bước quan trọng để các bên liên quan dễ		Tốt

Được quét bằng CamScanner

		dàng hình dung được cách mà hệ thống sẽ hiển thị trong tương lai, đồng thời giảm thiểu rủi ro khi triển khai thực tế. Việc này cũng giúp đội ngũ phát triển thuận lợi hơn trong việc nắm bắt yêu cầu, tránh tình trạng hiểu sai hoặc bỏ sót chức năng. Đến buổi chiều, sau khi hoàn tất phần phân tích và thiết kế giao diện, em tiến hành viết nội dung mô tả chi tiết và log ticket lên hệ thống. Trong ticket, em trình bày rõ hiện trạng hệ thống, những khó khăn mà người dùng đang gặp phải, đồng thời đưa ra đề xuất phát triển bao gồm việc bổ sung các trường dữ liệu mới và áp dụng phân quyền theo từng cấp người dùng. Toàn bộ nội dung được viết ngắn gọn, rõ ràng nhưng vẫn đảm bảo đủ chi tiết để nhóm phát triển có thể tiếp nhận và triển khai một cách chính xác. Thông qua quá trình này, em không chỉ thực hiện vai trò cầu nối giữa người dùng và đội ngũ kỹ thuật, mà còn góp phần nâng cao chất lượng hệ thống bằng việc đưa ra giải pháp cụ thể, trực quan và khả thi. Đây là một trải nghiệm quan trọng, giúp em rèn luyện kỹ năng phân tích nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp và trình bày giải pháp, đồng thời mang lại giá trị thiết thực cho dự án.		
17	05/09/2025 (8:00 – 17:30)	Hôm nay, em tập trung thực hiện các công việc của vai trò Business Analyst, chủ yếu là tìm hiểu, phân tích và làm rõ các luồng nghiệp vụ để hỗ trợ thiết kế và phát triển hệ thống. Buổi sáng, em dành thời gian nghiên cứu chi tiết các quy trình kho, từ nhập kho, kiểm tra hàng hóa, đối chiếu chứng từ đến cập nhật vào hệ thống, cũng như luồng xuất kho, bao gồm duyệt yêu cầu, trích xuất, đóng gói, vận chuyển và cập nhật tồn kho. Em còn khảo sát thêm các luồng nghiệp vụ như kiểm kê định kỳ, luân chuyển nội bộ hay xử lý hàng trả lại. Việc nắm bắt toàn diện giúp em hiểu rõ cách kho vận hành, nhận diện các điểm nghẽn, rủi ro, từ đó đề xuất cải tiến tối ưu quy trình, tăng tính minh bạch và giảm chi phí vận hành.		

Được quét bằng CamScanner

		Buổi chiều, em chuyển sang phân tích và thiết kế. Em rà soát và chỉnh sửa các ticket đã log, bổ sung mô tả rõ ràng, súc tích về bối cảnh, vấn đề và yêu cầu, đảm bảo nhóm phát triển nắm bắt nhanh và giảm thời gian trao đổi. Tiếp đó, em thiết kế lại giao diện trên Figma, sắp xếp bố cục trực quan hơn, bổ sung các trường thông tin cần thiết, tạo trải nghiệm người dùng logic và thuận tiện. Song song, em vẽ sơ đồ workflow minh họa dòng chảy nghiệp vụ và mối liên kết giữa các bước, giúp các bên tham gia dự án dễ hiểu dữ liệu luân chuyển, trách nhiệm từng vai trò và các điểm kiểm soát quan trọng, từ đó phát triển và kiểm thử chính xác, hạn chế sai sót. Qua các công việc trong ngày, em vừa củng cố kiến thức về quản lý kho và nghiệp vụ vận hành, vừa rèn luyện kỹ năng phân tích yêu cầu, mô hình hóa quy trình, thiết kế giao diện và trình bày giải pháp. Những nỗ lực này giúp em hoàn thiện vai trò cầu nối giữa người dùng và đội ngũ phát triển, đồng thời mang lại giá trị thực tế cho dự án, đảm bảo hệ thống sau triển khai đáp ứng đúng nhu cầu nghiệp vụ và thân thiện với người dùng.		
18	08/09/2025 (8:00 – 17:30)	Trong ngày hôm nay, em đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ của một Business Analyst, chủ yếu là tìm hiểu, phân tích và làm rõ các luồng nghiệp vụ cốt lõi để hỗ trợ thiết kế và phát triển hệ thống. Buổi sáng, em xử lý lại các hạng mục tồn đọng, bao gồm chỉnh sửa và vẽ lại giao diện quản lý yêu cầu trên Figma, khắc phục các sai sót trước đó và tối ưu trải nghiệm người dùng, đảm bảo bố cục trực quan, logic và dễ thao tác. Đồng thời, em rà soát và vẽ lại sơ đồ Workflow, bổ sung đầy đủ các bước và nhánh xử lý, kể cả các trường hợp ngoại lệ, giúp sơ đồ phản ánh sát quy trình vận hành và thuận tiện khi triển khai hệ thống. Bên cạnh đó, em cập nhật nội dung trên Jira và Confluence, đồng bộ với những điều chỉnh mới, đảm bảo các mô tả yêu cầu, bối cảnh nghiệp vụ và trạng thái công việc rõ ràng, minh bạch, hỗ trợ quản lý tiến độ hiệu quả. Buổi chiều, em tiếp tục tập trung vào việc tùy chỉnh giao diện phần mềm dựa trên bản thiết kế và sơ đồ Workflow đã hoàn thiện, rà soát các điểm khác biệt, đề xuất tối ưu trải nghiệm người dùng. Em phân nhóm các thay đổi thành bố cục hiển thị, trường dữ liệu và tính trực quan, điều chỉnh vị trí		Tớ

Được quét bằng CamScanner

		các trường thông tin, bổ sung các trường quan trọng và tinh chỉnh màu sắc, biểu tượng để dễ phân biệt và theo dõi tiến độ. Trong quá trình này, em phối hợp chặt chẽ với đội phát triển, minh họa trực tiếp các chỉnh sửa từ Figma và giải thích ý nghĩa nghiệp vụ, giúp đội kỹ thuật hiểu rõ lý do và tầm quan trọng của các thay đổi. Đồng thời, em cập nhật mô tả chi tiết trong ticket Jira để phản ánh đúng những điều chỉnh, đảm bảo tài liệu và công cụ quản lý luôn đồng bộ. Kết thúc ngày, em đã hoàn thành việc chỉnh sửa giao diện và đồng bộ hóa các tài liệu, nâng cao tính trực quan của hệ thống, đảm bảo các yêu cầu nghiệp vụ được phản ánh đầy đủ, rõ ràng và khả thi trong triển khai, đồng thời củng cố thêm kỹ năng phân tích, quan sát và kết nối giữa nghiệp vụ và giải pháp công nghệ.		
19	09/09/2025 (8:00 – 17:30)	Trong ngày làm việc hôm nay, em đã tham gia hỗ trợ hệ thống khám chữa bệnh, tiếp nhận và xử lý nhiều tình huống phát sinh tại các phòng khám, từ tiếp đón, kê đơn, quản lý hồ sơ đến liên thông dữ liệu giữa HIS – RIS – PACS. Ở PK Ngoại tiết niệu, em đã hướng dẫn bác sĩ hiệu chỉnh dữ liệu thời gian đo sinh hiệu của NB Phạm Thị Tải và xử lý trường hợp NB Kiều Thị Nhậm bị trùng hồ sơ, phối hợp Tekmedi gộp dữ liệu vào thẻ NB để bác sĩ theo dõi bệnh án trên một hồ sơ duy nhất. Tại PK Tim mạch can thiệp, em hướng dẫn xóa dịch vụ thừa cho NB Nguyễn Thị Loan khi bác sĩ không thao tác được do phân quyền hệ thống. Ở PK Hậu môn – trực tràng, em phối hợp bộ phận kho để xử lý NB Trần Bảo Toàn không thực hiện dịch vụ nội soi nhưng hệ thống báo lỗi, đảm bảo tính minh bạch hồ sơ và báo cáo vật tư. Tại PK Nội tiết – NTQ2, em hỗ trợ NB Nguyễn Thị Ưu khi phòng X-quang không tìm thấy tên, liên hệ PACS để rà soát và phối hợp với điều dưỡng, đảm bảo NB được thực hiện dịch vụ đúng lịch. Ở PK Cơ xương khớp, em xử lý trường hợp NB đổi mã thẻ nên không ra số thứ tự phát thuốc, hướng dẫn duyệt BHYT theo mã mới; tại PK Phẫu thuật tim và PK Tim mạch CT, em đồng bộ dữ liệu BHYT để đảm bảo mức hưởng chính xác và tránh nhầm lẫn hồ sơ. Ngoài ra, em hỗ trợ xử lý NB trùng mã, sai thẻ BHYT, hay lỗi liên thông HIS – RIS – PACS, phối hợp chặt chẽ với Tekmedi, điều dưỡng, bác sĩ, phòng KHTH và TCKT. Trong quá trình giải quyết, em luôn rút kinh nghiệm: kiểm tra đồng bộ thời gian định kỳ, xác nhận NB trước khi tất		

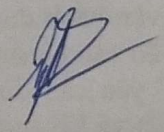
Được quét bằng CamScanner

		toán, phân quyền linh hoạt hơn cho bác sĩ, cảnh báo thẻ BHYT sắp hết hạn, và tăng cường giám sát hệ thống liên thông. Nhờ đó, các sự cố đều được khắc phục kịp thời, góp phần chuẩn hóa quy trình vận hành, nâng cao tính chuyên nghiệp trong phục vụ NB, đồng thời xây dựng hệ thống quản lý bệnh viện minh bạch và hiệu quả hơn.		
20	10/09/2025 (8:00 – 17:30)	Trong ngày làm việc 10.09.2025, em đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho quá trình phân tích nghiệp vụ, đảm bảo sự liền mạch trong triển khai và góp phần hoàn thiện cả về thiết kế lẫn truyền đạt yêu cầu cho đội phát triển. Buổi sáng, em rà soát toàn bộ các thiết kế tồn đọng trên Figma, phân tích phản hồi từ người dùng và đội phát triển để chỉnh sửa giao diện quản lý yêu cầu, tái cấu trúc bố cục, sắp xếp thông tin theo mức độ ưu tiên, bổ sung các trường còn thiếu và áp dụng màu sắc – biểu tượng nhất quán, giúp người dùng dễ thao tác và đội phát triển có cơ sở chuẩn xác để triển khai code. Song song, em cập nhật sơ đồ Workflow nghiệp vụ, bổ sung các nhánh phụ, xử lý ngoại lệ và mô tả rõ ràng các trạng thái, hành vi hệ thống và người dùng, tạo tài liệu tham chiếu hữu ích cho kiểm thử, đào tạo và phân tích rủi ro. Em cũng đồng bộ hóa tài liệu trên Jira và Confluence, cập nhật mô tả nghiệp vụ đầy đủ, liên kết với Figma và Workflow, đảm bảo thông tin chính xác, dễ hiểu và thống nhất giữa các hệ thống, hỗ trợ đội kỹ thuật và QA triển khai đúng hướng. Buổi chiều, em tập trung vào nghiệp vụ mới: bổ sung trường "Dị ứng thuốc" vào tab Đơn thuốc (Module Khám bệnh), phối hợp với nghiệp vụ làm rõ bối cảnh sử dụng, chỉnh sửa giao diện trên Figma, tạo hai ticket Jira cho Frontend và Backend với mô tả chi tiết, kèm bản thiết kế và sơ đồ Workflow, giúp đội phát triển nắm bắt nhanh và thực hiện chính xác. Phần còn lại của buổi chiều, em tinh chỉnh giao diện, rà soát nhãn trường, icon, tooltip, màu cảnh báo và trực tiếp trao đổi với lập trình viên về tính khả thi của các đề xuất, đảm bảo kết nối chặt chẽ giữa nghiệp vụ và kỹ thuật, tối ưu trải nghiệm người dùng và hỗ trợ vận hành hiệu quả hệ thống. Nhìn chung, các hoạt động trong ngày thể hiện vai trò trung tâm của em trong việc kết nối nghiệp vụ – kỹ thuật, hệ thống hóa thông tin và đảm bảo chất lượng triển khai dự án.		

Được quét bằng CamScanner

21	11/09/2025 (8:00 – 17:30)	Trong ngày 11.09.2025, với vai trò Business Analyst, em đã chủ động thực hiện nhiều hoạt động kiểm thử và hỗ trợ đội phát triển trong quá trình hoàn thiện hệ thống HIS. Công việc chính tập trung vào hai mảng: kiểm tra lại các hạng mục đã được Dev sửa theo yêu cầu từ các ticket trước đó và kiểm thử, phát hiện các lỗi mới còn tồn tại trong nhiều phân hệ quan trọng, nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động chính xác và đồng bộ với quy trình nghiệp vụ bệnh viện. Đối với phân hệ Điều trị nội trú, em đã re-test ticket liên quan đến hiển thị thông tin chẩn đoán chi tiết trên tờ điều trị theo ngày y lệnh mới nhất. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ luồng thao tác, dữ liệu hiện đã phản ánh đúng nghiệp vụ, đảm bảo tính chính xác và nhất quán cho người dùng. Trong phân hệ Nội trú, em phát hiện vấn đề liên quan đến trường "Chẩn đoán vào viện" chưa lấy dữ liệu chính xác từ thông tin nhập viện và chưa hỗ trợ chỉnh sửa trực tiếp trên phiếu. Em đã log ticket chi tiết kèm evidence và đề xuất bổ sung chức năng chỉnh sửa để hỗ trợ bác sĩ và điều dưỡng. Trong phân hệ Khám bệnh, em ghi nhận hệ thống tính ngày hẹn tái khám chưa đúng logic, dẫn đến ngày hẹn không trùng với thực tế. Em đã lập ticket mô tả rõ sai lệch và đề xuất điều chỉnh công thức tính toán để ngày hẹn tự động bám theo thời điểm kết luận khám, giúp giảm sai sót và tiết kiệm thời gian thao tác cho bác sĩ. Đối với phân hệ Truyền phát máu, em nhận thấy giao diện chỉ hiển thị danh sách chi tiết từng lần truyền mà chưa cung cấp tổng số lượng chế phẩm máu. Em đã log ticket mới kèm đề xuất bổ sung chức năng hiển thị tổng số lượng ngay trên màn hình chi tiết, giúp giám sát và kiểm soát an toàn truyền máu hiệu quả hơn. Tổng kết, trong ngày 11.09.2025 em đã vừa kiểm thử lại các hạng mục đã sửa, vừa phát hiện, log và mô tả chi tiết các vấn đề còn tồn đọng trong nhiều phân hệ quan trọng của HIS. Các ticket được cập nhật đầy đủ, kèm bằng chứng test để Dev dễ dàng phân tích và chỉnh sửa. Những hoạt động này không chỉ đảm bảo chất lượng sản phẩm mà còn hỗ trợ đội ngũ y tế sử dụng hệ thống thuận lợi, chính xác và hiệu quả hơn trong công việc hàng ngày.		

Được quét bằng CamScanner

22	12/09/2025 (8:00 – 17:30)	Trong ngày 12/09/2025, em đã tập trung thực hiện và hoàn thành nhiều công việc gắn với vai trò Business Analyst, bao gồm kiểm thử, re-test và log các ticket để đảm bảo hệ thống HIS vận hành đúng quy trình nghiệp vụ y tế. Cụ thể, em đã tiến hành kiểm thử chức năng đóng hồ sơ dịch vụ trong module Khám bệnh, phát hiện hệ thống chưa tự động chuyển trạng thái người bệnh khi có nhiều dịch vụ đồng thời, và đã lập ticket gửi BE xử lý để trạng thái người bệnh được cập nhật chính xác (Ticket:SAKURA-73789). Trong module Nội trú, em nhận thấy danh sách Tờ điều trị trong Droplist Thuốc đã kê chưa hiển thị đầy đủ tên, gây khó khăn cho việc tra cứu và kê đơn; em đã log ticket gửi FE để bổ sung thông tin, đồng thời tham khảo Figma thiết kế lại giao diện (Ticket: SAKURA-73840). Em cũng phát hiện bất cập trong giao diện Thực hiện CĐHA – TDCN, khi danh sách người bệnh hiển thị icon thay vì tên, và đã log ticket yêu cầu sửa đổi nhằm tăng tính trực quan (Ticket:SAKURA-73852; Figma). Trong quá trình kiểm thử chức năng nhập thời gian thực hiện thuốc, em phát hiện hệ thống cho phép điều chỉnh vượt giờ hiện tại, tiềm ẩn rủi ro ghi sai hồ sơ bệnh án; em đã log ticket để BE bổ sung cơ chế kiểm soát thời gian hợp lý (Ticket:SAKURA-73857). Bên cạnh đó, em cũng phối hợp re-test và xác nhận hoàn thành ticket liên quan đến việc ẩn trường "Dị ứng thuốc (Text)" trong tab Đơn thuốc – Module Khám bệnh, giúp giao diện tinh gọn, thao tác thuận tiện hơn (Tickets: SAKURA-73600;SAKURA-73833) Như vậy, trong ngày 12/09/2025, em đã hoàn thành đầy đủ các công việc theo vai trò Business Analyst, từ kiểm thử, phân tích nguyên nhân, log ticket đến re-test xác nhận kết quả chỉnh sửa. Những hoạt động này không chỉ đảm bảo chất lượng hệ thống HIS mà còn góp phần tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ y tế, hỗ trợ đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế thao tác chính xác, hiệu quả hơn trong công việc hằng ngày.		
23	15/09/2025 (8:00 – 17:30)	Trong ngày 15/09/2025, em đã tập trung triển khai và hoàn thành các công việc liên quan đến vai trò của một Business Analyst, bao gồm kiểm thử, re-test sau khi Dev chỉnh sửa và log các ticket mới nhằm đảm bảo hệ thống HIS vận hành đúng quy trình nghiệp vụ y tế. Cụ thể, em đã hoàn		

Được quét bằng CamScanner

		thiện version và chuyển trạng thái nhiều ticket như SAKURA-73857 (FE [Nội trú] bắt điều kiện không cho nhập thời gian sử dụng thuốc tương lai), SAKURA-73840 (FE [Nội trú] bổ sung tên và hiển thị tất cả Tờ điều trị tại Droplist Thuốc đã kê) và SAKURA-73981 (FE [Nội trú] thêm cột Cách truyền, Tốc độ truyền khi kê dịch vụ chế phẩm máu). Đồng thời, em chuyển trạng thái cho Dev thực hiện đẩy code với các ticket như SAKURA-73833 (FE [Thiết lập chung] ẩn trường Dị ứng thuốc), SAKURA-73634 (BE [Điều trị nội trú] hiển thị Chẩn đoán chi tiết tờ điều trị có ngày y lệnh mới nhất) và SAKURA-73600 (FE [Khám bệnh] thêm trường Dị ứng thuốc). Bên cạnh đó, em cũng log và kiểm thử các ticket mới, điển hình như SAKURA-74024 (BE [CĐHA - TDCN, Xét nghiệm, Khám bệnh, PTTT] không bắt trùng dịch vụ), SAKURA-74090 (BE [Nội trú] thêm cột Cách truyền, Tốc độ truyền) và SAKURA-74074 (FE [Editor - Tờ điều trị, Phiếu truyền máu] bổ sung Components Cách truyền và Tốc độ truyền). Trong quá trình test ticket, em đã kiểm thử và xác nhận các chức năng như SAKURA-73880 (BE [KNT.16] thêm bộ lọc Người tạo QR, key Năm sinh, số hóa đơn), SAKURA-73980 (FE [KNT.16] thêm bộ lọc Người tạo QR), SAKURA-73733 (FE [Truyền phát máu] hiển thị tổng số lượng chế phẩm máu) và SAKURA-73706 (FE [Khám bệnh] chỉnh sửa cách tính ngày hẹn tái khám theo thời gian kết luận khám). Toàn bộ công việc trong ngày đã được em thực hiện đầy đủ theo vai trò Business Analyst: từ kiểm thử, phân tích nguyên nhân, log ticket đến re-test và xác nhận kết quả chỉnh sửa. Các nội dung này không chỉ đảm bảo chất lượng hệ thống HIS mà còn góp phần tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ y tế, hỗ trợ đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế thao tác hiệu quả và chính xác hơn trong công việc hằng ngày.		
24	16/09/2025 (8:00 – 17:30)	Trong ngày 16/09/2025, em đã tập trung triển khai và hoàn thành nhiều công việc gắn liền với vai trò Business Analyst, bao gồm kiểm thử, re-test sau khi Dev chỉnh sửa và log các ticket mới để đảm bảo hệ thống HIS vận hành đúng quy trình nghiệp vụ y tế. Cụ thể, em đã test và log các yêu cầu bổ sung như BE (CR0231 - BVCR) thiết lập điều kiện "Trả máu" yêu cầu duyệt trả trước khi cho người bệnh ra viện (SAKURA-74212) và FE tương ứng hiển thị trực quan điều kiện này trên giao diện		

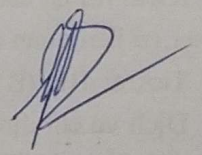
Được quét bằng CamScanner

		(SAKURA-74173), nhằm kiểm soát chặt chẽ quy trình, giảm rủi ro thất thoát chế phẩm máu và nâng cao an toàn người bệnh. Đồng thời, em xử lý BE (QLYC-3014 - PSTW) liên kết dữ liệu "Cách truyền" và "Tốc độ truyền" vào phiếu yêu cầu để giảm thao tác nhập liệu lặp lại, đảm bảo dữ liệu chính xác khi quản lý truyền máu (SAKURA-74216). Sau khi Dev đẩy code, em re-test các tính năng như BE (OP - NTTW) không bắt trùng dịch vụ ở trạng thái Hoàn đổi (SAKURA-74024) và FE (OP - BVCR) chuyển đổi icon từ Tiện ích sang Tên người bệnh để giao diện trực quan hơn (SAKURA-73852), giúp quy trình tác nghiệp mượt mà, giảm phiền hà cho nhân viên và người bệnh. Bên cạnh đó, em cũng test các ticket trên Stable gồm BE (OP-CR) thêm bộ lọc Người tạo QR và key Năm sinh, số hóa đơn (SAKURA-73880), FE (OP-CR) thêm bộ lọc Người tạo QR (SAKURA-73980), FE (QLYC-3004/BVCR) hiển thị tổng số lượng chế phẩm máu trong Chi tiết truyền phát máu (SAKURA-73733), FE (QLYC-3005/BVCR) chỉnh sửa cách tính ngày hẹn tái khám (SAKURA-73706), tuy hiện tại chưa thấy thay đổi so với Test – SAKURA nên vẫn chưa chuyển trạng thái. Như vậy, toàn bộ công việc trong ngày đã được em thực hiện trọn vẹn theo vai trò BA: từ kiểm thử, phân tích, log ticket đến re-test xác nhận kết quả, góp phần nâng cao trải nghiệm end-user, đảm bảo hệ thống HIS ổn định, chính xác và hỗ trợ đội ngũ y tế thao tác hiệu quả hơn trong công việc hằng ngày.		
25	17/09/2025 (8:00 – 17:30)	Trong ngày 17/09/2025, em đã tập trung triển khai và hoàn thành các công việc của một Business Analyst, bao gồm kiểm thử, xác nhận kết quả sau khi Dev chỉnh sửa và log các ticket mới để đảm bảo hệ thống HIS đáp ứng đúng quy trình nghiệp vụ y tế. Em đã kiểm tra và log ticket cho các yêu cầu bổ sung trên cả backend và frontend. Cụ thể, em đã log yêu cầu bổ sung trường Mã BA tại Popup HSBA người bệnh để đồng bộ dữ liệu với hồ sơ bệnh án (SAKURA-74323) và đảm bảo hiển thị đúng trên giao diện, giúp nhân viên y tế tra cứu chính xác. Em cũng thêm trường Địa điểm tại các loại hội chẩn như Khám chuyên khoa và Hội chẩn qua mổ (SAKURA-74329) để hồ sơ hội chẩn rõ ràng và dễ quản lý. Với bệnh viện PSTW, em thực hiện kiểm tra và log các ticket liên quan đến dịch vụ chế phẩm máu, bao gồm thêm cột Cách truyền, Tốc độ		

Được quét bằng CamScanner

		truyền trên frontend (SAKURA-73981, SAKURA-74074) và backend (SAKURA-74090, SAKURA-74216) để dữ liệu được lưu trữ và liên kết đồng bộ, đảm bảo minh bạch trong quá trình truyền máu. Bên cạnh đó, em đã hoàn tất test và chuyển trạng thái ticket cho việc thêm trường mã chuẩn chi trong module Kế toán – Tài chính (SAKURA-74262), hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu. Khi test trực tiếp trên hệ thống BVCR, em phát hiện và log lỗi liên quan đến "Dịch vụ kèm theo" khi kê DVKT (SAKURA-74312), đồng thời đảm bảo việc cập nhật mã BA mới khi sửa loại bệnh án trên frontend và backend (SAKURA-74324, SAKURA-74340). Toàn bộ các công việc trong ngày được em thực hiện từ test, phân tích nguyên nhân, log ticket đến re-test xác nhận kết quả, góp phần đảm bảo chất lượng hệ thống HIS, tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ y tế, hỗ trợ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế thao tác chính xác, hiệu quả hơn trong công việc hàng ngày.		
26	18/09/2025 (8:00 – 17:30)	Trong ngày 18/09/2025, em đã tập trung triển khai và hoàn thành nhiều công việc theo vai trò Business Analyst, bao gồm kiểm thử, re-test và log ticket nhằm đảm bảo hệ thống HIS đáp ứng đúng quy trình nghiệp vụ y tế. Buổi sáng, em đã kiểm tra lại yêu cầu và bổ sung ticket cho BV PSTW, cụ thể: tại Frontend module Quản lý yêu cầu, phần Editor của Tờ điều trị và Phiếu truyền máu, em đã bổ sung các thành phần Cách truyền và Tốc độ truyền cho dịch vụ chế phẩm máu (SAKURA-74074); tại Backend module Nội trú, em liên kết dữ liệu từ các cột Cách truyền, Tốc độ truyền khi kê dịch vụ chế phẩm máu vào phiếu yêu cầu (SAKURA-74216) và bổ sung cột Cách truyền, Tốc độ truyền, Đơn vị tốc độ truyền tại Frontend (SAKURA-73981). Sau khi kiểm tra, em test kỹ lưỡng và chuyển các ticket lên Stable, đồng thời hoàn tất bổ sung cột tương ứng ở Backend (SAKURA-74090) để đảm bảo tính nhất quán dữ liệu. Buổi chiều, em được phân công học thêm về báo cáo ADR – một loại báo cáo quan trọng liên quan đến ghi nhận và quản lý phản ứng có hại của thuốc. Em đã nghiên cứu luồng xử lý từ ghi nhận dữ liệu tại các khoa phòng đến tổng hợp báo cáo, đồng thời tìm hiểu bản chất và ý nghĩa của ADR trong việc đảm bảo an toàn người bệnh. Trong quá trình học, em chủ động đặt câu hỏi về các tiêu chí lập báo cáo, cách xử lý dữ liệu thiếu		

Được quét bằng CamScanner

		hoặc trùng lặp, từ đó nhận thấy cần rèn luyện tư duy phân tích, tính cẩn thận và kỹ năng tổng hợp thông tin. Song song với học ADR, em tiếp tục test và log ticket cho BVCR và BV NDTP. Tại Backend module Khám bệnh của NDTP, em bắt điều kiện trạng thái người bệnh để tránh thao tác không hợp lệ (SAKURA-74362). Đồng thời, em phát hiện trường hợp dữ liệu cân nặng, chiều cao của bệnh nhân NT250022828 tại module Nội trú chưa đồng bộ với phiếu GMHS, em đã ghi nhận chi tiết và báo Dev xử lý. Tại BVCR, em cải thiện chức năng nhập cân nặng cho bệnh nhân dưới 1 tuổi ở phiếu theo dõi GMHS (SAKURA-74430) để đảm bảo dữ liệu chính xác, phục vụ quyết định lâm sàng. Như vậy, toàn bộ công việc trong ngày 18/09/2025, từ kiểm thử, phân tích, log ticket đến re-test, em đều thực hiện theo đúng vai trò Business Analyst, góp phần đảm bảo chất lượng hệ thống HIS và tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ y tế, hỗ trợ đội ngũ y tế thao tác hiệu quả, chính xác hơn.		
27	19/09/2025 (8:00 – 17:30)	Trong ngày 19/09/2025, em đã tập trung triển khai và hoàn thành nhiều công việc của một Business Analyst, bao gồm kiểm thử, re-test và log ticket nhằm đảm bảo hệ thống HIS vận hành đúng quy trình nghiệp vụ y tế. Em đã kiểm thử toàn bộ chức năng trên môi trường Stable và server chính thức, cập nhật trạng thái vào phiếu yêu cầu hàng tuần để theo dõi minh bạch, góp phần duy trì quy trình quản lý thay đổi chuyên nghiệp. Trong phân hệ Khám bệnh, em phát hiện lỗi không chuyển trạng thái người bệnh khi hồ sơ DV 1 đã đóng nhưng DV 2 chưa kết thúc (SAKURA-73789), mô phỏng nhiều tình huống thực tế và báo cáo chi tiết cho đội phát triển. Với phân hệ Truyền phát máu, em kiểm thử tính năng hiển thị tổng số lượng theo từng chế phẩm máu trong giao diện chi tiết, đảm bảo dữ liệu chính xác và ổn định (SAKURA-73733). Đồng thời, em chỉnh sửa và kiểm thử cách tính ngày hẹn tái khám trong phân hệ Khám bệnh, để hệ thống tự động tính dựa trên thời điểm kết luận khám, nâng cao tính linh hoạt và phù hợp với tình trạng bệnh nhân (SAKURA-73706). Trong phân hệ Hội chẩn, em bổ sung trường "Địa điểm" cho các loại hội chẩn nhằm cải thiện khả năng lập kế hoạch và tra cứu thông tin (SAKURA-74329). Em cũng tiến hành cập nhật phiên bản		

Được quét bằng CamScanner

		PIC_SAKURA_Version để đồng bộ dữ liệu, giữ hệ thống vận hành trơn tru. Ở phân hệ CĐHA – TDCN, em kiểm thử các tình huống bệnh nhân bảo hiểm được chỉ định thuốc kèm DVKT áp dụng Thông tư 20, phát hiện và báo cáo chi tiết các bất cập (SAKURA-74312). Bên cạnh đó, em phát hiện và đề xuất hướng xử lý bug liên quan đến lọc thuốc trong danh sách đã kê ở phân hệ Nội trú, phối hợp với Backend để cải thiện tính chính xác khi tra cứu (SAKURA-74535, SAKURA-74556). Cuối cùng, em log ticket mới cho BVBP, bổ sung trường hiển thị dịch vụ CLS Ngoại trú và đơn thuốc Ngoại trú trong phiếu theo dõi điều trị YHCT, giúp phiếu đầy đủ và thuận tiện hơn (SAKURA-74538). Toàn bộ công việc trong ngày đã được em thực hiện từ kiểm thử, phân tích nguyên nhân, log ticket đến re-test xác nhận kết quả chỉnh sửa, góp phần nâng cao chất lượng hệ thống HIS và tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ y tế, hỗ trợ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế thao tác hiệu quả, chính xác hơn.		
28	22/09/2025 (8:00 – 17:30)	Trong ngày 22/09/2025, em đã tập trung triển khai và hoàn thành nhiều công việc gắn liền với vai trò của một Business Analyst, bao gồm cả hoạt động kiểm thử (testing), xác nhận kết quả sau khi Dev chỉnh sửa (re-test) và phát hiện, ghi nhận (log) các ticket mới để đảm bảo hệ thống HIS đáp ứng đúng quy trình nghiệp vụ y tế. Cụ thể: Kiểm tra lại các Ticket đã log nhưng chưa hoàn thiện và bổ sung các Ticket có liên quan (vừa cho FE và BE): • Ticket: BE (BVBP0005) [Phiếu điều trị YHCT] Liên kết dữ liệu Dịch vụ chỉ định CLS Ngoại trú, Đơn thuốc ngoại trú vào Phiếu theo dõi điều trị YHCT/PHCN • Ticket: FE (BVBP0005) [Editor - Tờ điều trị YHCT] Hiển thị trường DV CLS Ngoại trú, Đơn thuốc Ngoại trú vào cột Chỉ định trên Phiếu theo dõi điều trị • Tiến hành Kiểm thử lại trên môi trường Test, Stable và bắt đầu chuyển trạng thái các Ticket đã log từ các ngày trước đó: • Ticket: FE (QLYC-3014 - PSTW) [Nội trú] Thêm cột Cách truyền,		

Được quét bằng CamScanner

		Tốc độ truyền, Đơn vị tốc độ truyền khi kê các dịch vụ chế phẩm máu • Ticket: BE (OP - BVCR) [Phiếu theo dõi GMHS] Cải thiện phần nhập cân nặng với NB < 1 tuổi • Ticket: FE (QLYC-3056/NDTP.0405) [Khám bệnh] Bổ sung trường Mã BA tương tự MH HSBA tại Popup HSBA Người bệnh Em đã dành thời gian tìm hiểu và giải quyết một lỗi trên phiếu theo dõi truyền dịch và liên hệ với người yêu cầu để confirm lại yêu cầu • Ticket: [PSHN] Cải thiện Phiếu theo dõi truyền dịch (EMR_HSDD015.3): Trường Khoa trên header mặc định lấy theo Khoa tạo phiếu Bên cạnh các nhiệm vụ đã hoàn thành, có những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn hơn: Kiểm tra và log lỗi API liên quan đến Ticket của bệnh viện PSTW • API Tổng hợp Tồn kho: Khi kiểm tra API này, em đã phát hiện ra lỗi. API đang trả về trường cachDung thay vì cachTruyen, dẫn đến việc dữ liệu không hiển thị đúng. • API: PUT https://api-sakura-test.isofh.vn/api/his/v1/kho-ton-kho/tong-hop?page=0&size=500 • API Dịch vụ Chế phẩm máu: Tương tự, em đã kiểm tra API này và xác nhận rằng nó đang thiếu các trường tocDoTruyen và donViTocDoTruyen. • API: GET https://api-sakura-test.isofh.vn/api/his/v1/nb-dv-che-pham-mau/tong-hop?active=true&nbDotDieuTriId=494806&chiDinhTuDichVuId=307903&chiDinhTuLoaiDichVu=210&dsTrangThaiHoan=0%2C10%2C20		

Được quét bằng CamScanner

		Việc kiểm tra và so sánh từng API rất mất thời gian, nhưng em đã log đầy đủ các ticket để đội ngũ BE hỗ trợ xử lý, đảm bảo dữ liệu hiển thị chính xác và đầy đủ trên hệ thống. Hai ticket liên quan đến cải thiện phiếu GMHS và bổ sung mã BA đòi hỏi phải thao tác nhiều bước phức tạp mới có thể test thành công. Mặc dù mất nhiều thời gian, nhưng kết quả cuối cùng đã đáp ứng được kỳ vọng, cho thấy sự chính xác của các bản cập nhật. • Ticket: BE (OP - BVCR) [Phiếu theo dõi GMHS] Cải thiện phần nhập cân nặng với NB < 1 tuổi • Ticket: FE (QLYC-3056/NDTP.0405) [Khám bệnh] Bổ sung trường Mã BA tương tự MH HSBA tại Popup HSBA Người bệnh Một ticket khác liên quan đến việc lọc thuốc trong danh sách đã kê vẫn đang trong quá trình kiểm thử. Em đã thử nhiều trường hợp khác nhau nhưng vẫn chưa thể chuyển trạng thái Pass done, vì nó phụ thuộc vào một ticket liên quan của đội FE. Em sẽ tiếp tục theo dõi và làm việc chặt chẽ để hoàn thành sớm nhất. • Ticket: BE (QLYC-3088/BVCR) [Nội trú] Lọc thuốc trong danh sách thuốc đã kê theo Params Tờ điều trị Không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao, em đã dành thời gian để tìm hiểu sâu hơn về báo cáo ADR (phản ứng có hại của thuốc). Đây là một mảng kiến thức mới và rất quan trọng mà em đã được phân công phụ trách trong thời gian tới. Nhận thức được tầm quan trọng của việc này, em đã không chờ đợi đến khi có ca hỗ trợ cụ thể mới bắt đầu tìm hiểu. Thay vào đó, em chủ động nghiên cứu các tài liệu liên quan trên Confluence, một kho tri thức khổng lồ của công ty. Em đã đọc kỹ từng quy trình, từng quy định về cách thức báo cáo, các mẫu biểu cần điền, và cách xử lý khi gặp một		

Được quét bằng CamScanner

		trường hợp ADR thực tế. Việc này giúp em có một cái nhìn tổng quan và hệ thống về toàn bộ quy trình, thay vì chỉ giải quyết từng vấn đề một cách rời rạc. Sau khi nắm vững lý thuyết, em đã bắt tay vào thực hành. Em đã dành nhiều giờ để thao tác trực tiếp trên các môi trường Test và Stable. Từng bước một, em thử nghiệm việc tạo báo cáo, nhập liệu thông tin, và kiểm tra luồng dữ liệu. Quá trình thực hành này không chỉ giúp em làm quen với các công cụ mà còn giúp em phát hiện ra những điểm có thể gây khó khăn trong quá trình làm việc thực tế. Như vậy, toàn bộ công việc trong ngày 22.09.2025 đã được em thực hiện theo đúng vai trò của một Business Analyst: từ kiểm thử, phân tích nguyên nhân, log ticket đến re-test xác nhận kết quả chỉnh sửa. Các nội dung này không chỉ đảm bảo chất lượng hệ thống HIS mà còn góp phần quan trọng trong việc tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ y tế, hỗ trợ đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế thao tác hiệu quả, chính xác hơn trong công việc hằng ngày.		
29	23/09/2025 (8:00 – 17:30)	Trong ngày 23.09.2025, em đã hoàn thành các công việc của Business Analyst gồm kiểm thử, phân tích, log ticket và re-test kết quả. Những hoạt động này không chỉ giúp đảm bảo chất lượng hệ thống HIS mà còn hỗ trợ tối ưu quy trình, nâng cao hiệu quả làm việc cho đội ngũ y tế. 1. Trong ngày làm việc, em đã tiến hành kiểm thử lại toàn bộ các Ticket đang trong giai đoạn hoàn thiện để đảm bảo các lỗi đã được khắc phục triệt để và chức năng hoạt động đúng như yêu cầu ban đầu. Sau khi hoàn tất quá trình kiểm thử, em chủ động cập nhật trạng thái cho từng Ticket tương ứng, bao gồm các trạng thái như “Resolved”, “Closed” hoặc “Reopen” tùy theo kết quả thực tế. Việc này giúp đảm bảo tiến độ công việc được theo dõi sát sao, đồng thời hỗ trợ đội Phát triển (Dev) và Quản lý dự án (PM) nắm bắt chính xác tình hình xử lý lỗi hiện tại.		

Được quét bằng CamScanner

		• **FE (QLYC-3045/BVCR) [CĐHA-TDCN]**: Bật popup khi NB BH chỉ định thuốc kèm DVKT áp dụng TT20 nhưng không thành công --> Đã chuyển trạng thái sang đẩy lên Stable. • **FE (CR0238/BVCR) [Nội trú]:** Không bắt thời gian kết thúc khi cho dùng thuốc theo thiết lập chung. --> Đã test lại và thành công. • **BE (QLYC-3088/BVCR) [Nội trú]:** Lọc thuốc trong danh sách đã kê theo Params Tờ điều trị (đang kiểm tra lại do hiện tại chưa test thành công trên môi trường Test). --> Cần test lại do phía FE phải hoàn thành và Test cùng nhau. **2.** Em đã thực hiện kiểm thử trên môi trường Stable nhằm rà soát lại chức năng bộ lọc Hồ sơ bệnh án (HSBA), phát hiện và ghi nhận những bất thường trong quá trình vận hành thực tế. Dựa trên kết quả test, em đã log thêm các Ticket mới phản ánh chi tiết các lỗi phát sinh cũng như đề xuất hướng khắc phục cụ thể để đội kỹ thuật có thể xử lý kịp thời. Mục tiêu của hoạt động này là góp phần nâng cao tính ổn định và độ chính xác của hệ thống, đặc biệt đối với chức năng quan trọng trong việc tra cứu và quản lý HSBA. • **FE (CR0259/BVCR) [Hồ sơ bệnh án]** Bổ sung chức năng Tìm kiếm theo Bệnh án và lọc hiển thị Hồ sơ thuộc Bệnh án **3.** Trong quá trình kiểm tra dữ liệu trả về từ các API liên quan đến nghiệp vụ kê chế phẩm máu, em phát hiện một số trường hợp API chưa trả đúng hoặc còn thiếu thông tin cần thiết. Em đã lập Ticket bổ sung nhằm yêu cầu điều chỉnh, đảm bảo các API trả đúng và đầy đủ các trường dữ liệu cần thiết cho nghiệp vụ. Việc này không chỉ giúp hệ thống hoạt động chính xác hơn mà còn góp phần hỗ trợ đội ngũ người dùng cuối (đặc biệt là bác sĩ và điều dưỡng) trong quá trình thao tác trên phần mềm.		

Được quét bằng CamScanner

		• **BE (QLYC-3014 - PSTW) [Nội trú]** Chỉnh sửa, Bổ sung API trả đúng trường liên kết dữ liệu khi kê các dịch vụ chế phẩm máu --> Đã tiến hành Log và chuyển sang Dev thực hiện **4.** Đối với Ticket BE mã QLYC-3045/BVCR liên quan đến lỗi hệ thống khi bệnh nhân bảo hiểm (NB BH) chỉ định thuốc kèm dịch vụ kỹ thuật (DVKT) áp dụng theo Thông tư 20, em đã tiến hành kiểm thử lại từ phía Front-end (FE). Trong trường hợp kết quả test từ FE vẫn không thành công, em phối hợp với đội Back-end (BE) để đề nghị trả lỗi, giúp đội FE có cơ sở chỉnh sửa phù hợp. Hiện tại, em đã hoàn tất phần test ở FE và đang chờ phản hồi từ BE để thực hiện bước tiếp theo; nếu hệ thống hoạt động đúng, em sẽ tiến hành Reject Ticket vì lỗi đã được xử lý hoàn chỉnh ở phía FE. **5.** Ngoài các công việc trên, em tiếp tục thực hiện kiểm thử và log thêm nhiều Ticket khác theo đúng sự phân công được giao. Các Ticket này bao gồm cả lỗi nhỏ trong giao diện, luồng nghiệp vụ cũng như những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành thực tế. Em luôn đảm bảo quá trình log được thực hiện rõ ràng, có minh chứng cụ thể để thuận tiện cho đội Dev trong việc tái hiện và xử lý lỗi hiệu quả. • **NDTP.0410**-Phát thuốc ngoại trú, ra viện: Sửa lại logic thời gian tạo phiếu • **[HHTW]** Danh mục quyền: Cho phép bỏ gán vai trò ở quyền Bên cạnh các nhiệm vụ được giao, em chủ động thực hiện kiểm thử thêm các Ticket đã ở trạng thái "Cần Test Stable" để đẩy tiến độ cập nhật trạng thái lên hệ thống. Đồng thời, em tiến hành test và kiểm tra lại các API, rà soát các trường dữ liệu có khả năng sai sót, từ đó log thêm các Ticket mới để kịp thời khắc phục. Việc chủ động mở rộng phạm vi kiểm thử ngoài kế hoạch giúp đảm bảo chất lượng tổng thể của hệ thống và		

Được quét bằng CamScanner

		giảm thiểu rủi ro phát sinh trong các giai đoạn sau. • **FE (CR0238/BVCR) [Nội trú]** Không bắt thời gian kết thúc khi cho dùng thuốc theo thiết lập chung • **FE (QLYC-3056/NDTP.0405) [Khám bệnh]** Bổ sung trường Mã BA tương tự MH HSBA tại Popup HSBA Người bệnh --> Test hoàn thành trên môi trường Stable • **FE (QLYC-3014 - PSTW) [Nội trú]** Thêm cột Cách truyền, Tốc độ truyền, Đơn vị tốc độ truyền khi kê các dịch vụ chế phẩm máu --> Test hoàn thành • **FE (QLYC-3045/BVCR) [CĐHA-TDCN]** Bật Popup khi NB BH chỉ định thuốc kèm theo DVKT có áp dụng TT20 không thành công **BE (QLYC-3126/NDTP) [Đơn thuốc ra viện]** Chỉnh sửa Logic thời gian tạo mới đơn thuốc		
30	24/09/2025 (8:00 – 17:30)	Trong ngày 24.09.2025, em đã hoàn thành các công việc của Business Analyst gồm kiểm thử, phân tích, log ticket và re-test kết quả. Những hoạt động này không chỉ giúp đảm bảo chất lượng hệ thống HIS mà còn hỗ trợ tối ưu quy trình, nâng cao hiệu quả làm việc cho đội ngũ y tế. 1. Trong ngày làm việc, em đã bắt đầu thực hiện kiểm thử đối với các Ticket đã hoàn tất xử lý ở môi trường Dev, chuẩn bị cho quá trình đẩy lên môi trường Stable. Sau khi kiểm tra và đảm bảo các chức năng hoạt động ổn định, em tiến hành chuyển trạng thái Ticket lên Server nhằm xác nhận rằng các lỗi đã được khắc phục thành công. Công việc này giúp đảm bảo quy trình triển khai diễn ra thông suốt và giảm thiểu rủi ro phát sinh trong giai đoạn vận hành thực tế: BE (QLYC-3014 - PSTW) [Nội trú] Thêm cột Tốc độ truyền khi kê các dịch vụ chế phẩm máu		

Được quét bằng CamScanner

		BE (QLYC-3014 - PSTW) [Nội trú] Thêm cột Cách truyền, Tốc độ truyền khi kê các dịch vụ chế phẩm máu ⇨ Cả 2 Ticket trên đều chờ 1 Ticket khác đang được thực hiện, cùng nhau hoàn tất thì mới có thể Passed Test và Passed Stable. BE (OP - BVCR) [Phiếu theo dõi GMHS] Cải thiện phần nhập cân nặng với NB < 1 tuổi --> Test hoàn thành BE (QLYC-3126/NDTP) [Đơn thuốc ra viện] Không cập nhật thời gian tạo mới đơn thuốc ra viện với đơn thuốc đã phát --> Test hoàn thành ----> Resolve với Ticket yêu cầu: NDTP.0410-Phát thuốc ngoại trú, ra viện: Sửa lại logic thời gian tạo phiếu (Đã thực hiện) 2. Bên cạnh việc kiểm thử, em rà soát lại toàn bộ các Ticket đã log trước đó để chỉnh sửa, bổ sung thêm thông tin chi tiết như bước tái hiện lỗi, ảnh minh họa, hoặc mô tả rõ ràng hơn về điều kiện phát sinh lỗi. Việc hoàn thiện nội dung Ticket giúp đội ngũ Phát triển (Dev) dễ dàng hiểu và xử lý nhanh chóng, tránh sai sót trong quá trình fix lỗi. Đây là bước quan trọng giúp tối ưu hiệu quả phối hợp giữa các nhóm và đảm bảo chất lượng đầu ra của hệ thống. FE (OP - BVCR) [Lập bệnh án] Khi sửa loại bệnh án thì cập nhật luôn cả mã BA mới theo thiết lập chung BE (OP - BVCR) [Lập bệnh án] Khi sửa loại bệnh án thì cập nhật luôn cả mã BA mới theo thiết lập chung ==> Chỉnh sửa lại theo hướng mới khi đã có sự thống nhất từ Dev BE 3. Em đã tiếp tục thực hiện kiểm thử lại hai Ticket đang ở trạng thái "Resolve". Sau khi xác nhận các lỗi đã được xử lý đúng theo yêu cầu và không còn phát sinh vấn đề mới, em tiến hành cập nhật trạng thái của		

Được quét bằng CamScanner

		trong từng object con bên trong dsChiSoSong --> Đã hoàn thành Test trên Stable BE (OP - BVCR) [Phiếu theo dõi GMHS] Cải thiện phần nhập cân nặng với NB < 1 tuổi --> Đã hoàn thành Test trên Stable		
31	25/09/2025 (8:00 – 17:30)	Trong ngày 25.09.2025, em đã hoàn thành các công việc của Business Analyst gồm kiểm thử, phân tích, log ticket và re-test kết quả. Những hoạt động này không chỉ giúp đảm bảo chất lượng hệ thống HIS mà còn hỗ trợ tối ưu quy trình, nâng cao hiệu quả làm việc cho đội ngũ y tế. 1. Trong ngày, em đã bắt đầu tiến hành kiểm thử các Ticket đã hoàn thiện ở môi trường Test, chuẩn bị cho quá trình đẩy lên Stable. Sau khi đảm bảo các chức năng hoạt động đúng yêu cầu, em chủ động cập nhật trạng thái để đẩy lên Server, giúp hệ thống đồng bộ và sẵn sàng cho giai đoạn triển khai chính thức. FE (OP-CR) [KNT16] Thêm bộ lọc trạng thái đơn --> Test hoàn thành trên Stable BE (OP-CR) [KNT16] Thêm bộ lọc trạng thái đơn --> Test hoàn thành trên Stable BE (QLYC-3126/NDTP) [Đơn thuốc ra viện] Không cập nhật thời gian tạo mới đơn thuốc ra viện với đơn thuốc đã phát --> Hoàn thành test trên Stable 2. Em tiến hành rà soát, kiểm thử lại các tính năng đã được đội Dev nâng cấp hoặc chỉnh sửa trong các môi trường Test, Stable và Server. Mục tiêu là đảm bảo rằng các thay đổi mới không ảnh hưởng đến các chức năng hiện có, đồng thời duy trì tính ổn định và hiệu suất của hệ thống. BE (QLYC-3014 - PSTW) [Nội trú] Chỉnh sửa, Bổ sung		

Được quét bằng CamScanner

		API trả đúng trường liên kết dữ liệu khi kê các dịch vụ chế phẩm máu --> Hoàn thành Test BE (QLYC-3014 - PSTW) [Nội trú] Thêm cột Tốc độ truyền khi kê các dịch vụ chế phẩm máu --> Test hoàn thành BE (QLYC-3014 - PSTW) [Nội trú] Thêm cột Cách truyền, Tốc độ truyền khi kê các dịch vụ chế phẩm máu --> Test hoàn thành 3. Trong quá trình test, nếu phát hiện bất kỳ lỗi phát sinh hoặc tình huống không thể tái hiện được luồng xử lý, em đều chủ động phản hồi ngay cho đội Dev. Việc trao đổi kịp thời giúp hai bên phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng xác định nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục, đảm bảo tiến độ chung của dự án không bị gián đoạn. BE (QLYC-2994/BVCR) [Phiếu Biên bản hội chuẩn] Trường "Chẩn đoán vào viện" trên phiếu lấy từ CD vào viện của NB và cho chỉnh sửa được trên phiếu --> Reject vì đã tự sửa trên HIS Sever 4. Em tiến hành test lại các Ticket đã ở trạng thái "Resolve" để xác nhận rằng các lỗi đã được khắc phục hoàn toàn. Bên cạnh đó, em theo dõi sát các Ticket liên quan đang chờ "Done" để sẵn sàng thực hiện bước kiểm thử cuối cùng khi đội Dev hoàn tất xử lý. Hoạt động này giúp duy trì sự liên tục trong quá trình kiểm thử và tránh bỏ sót lỗi. BE (OP - BVCR) [Lập bệnh án] Khi sửa loại bệnh án thì cập nhật luôn cả mã BA mới theo thiết lập chung --> Test hoàn thành và chờ FE để đánh Pass cả hai và đẩy cùng lúc 5. Theo đúng kế hoạch phân công, em tập trung kiểm thử		

Được quét bằng CamScanner

		các Ticket thuộc phạm vi phụ trách, đồng thời ghi nhận lại chi tiết kết quả test và log đầy đủ các thông tin liên quan. Việc này giúp đảm bảo minh bạch, thuận tiện cho việc theo dõi tiến độ cũng như hỗ trợ Dev trong việc tái hiện và xử lý lỗi. FE (QLYC-3124/BVCR) [Chi tiết khám sàng lọc] Bổ sung cửa sổ xem trước khi in Bảng kê chi phí tổng hợp BE (QLYC-3125/HHTW) [Danh mục quyền] Bổ sung thêm tính năng cho phép bỏ gán vai trò ở Quyền FE (QLYC-3091/NTTW) [Form phiếu] Thêm vị trí phiếu in của EMR_BA389 tại mã vị trí 00602 - In điều dưỡng 6. Em đã chủ động trao đổi, phối hợp cùng các Dev phụ trách để thống nhất quy trình xử lý và tiến hành kiểm thử cuối, hoàn tất và chuyển trạng thái "Done" cho 2 Ticket. Hoạt động này thể hiện tinh thần chủ động, hợp tác và trách nhiệm trong việc đảm bảo chất lượng chung của dự án. BE (QLYC-3088/BVCR) [Nội trú] Lọc thuốc trong danh sách thuốc đã kê theo Params Tờ điều trị FE (QLYC-3088/BVCR) [Nội trú] Lọc thuốc trong danh sách thuốc đã kê ===> Chưa Hoàn thành vì đang đợi Build và Test lại Ngoài những nhiệm vụ được giao, em vẫn duy trì việc rà soát, kiểm tra tổng thể hệ thống để phát hiện sớm các lỗi tiềm ẩn. Đồng thời, em hỗ trợ nhóm trong việc kiểm thử nhanh một số chức năng mới phát sinh và đóng góp ý kiến để tối ưu trải nghiệm người dùng trong quá trình sử dụng phần mềm. Reject Ticket BE (QLYC-3045/BVCR) [CĐHA-TDCN] Báo lỗi khi NB BH chỉ định thuốc kèm theo DVKT có áp dụng		

Được quét bằng CamScanner

		TT20 --> FE đã thực hiện và Test thành công trên Stable Reject Ticket FE (OP - PSHN) [Thông tin ra viện] Mặc định Thủ trưởng đơn vị trong phần thông tin ra viện là tên Giám đốc bệnh viện theo thiết lập chung --> Đã tìm ra Ticket liên quan trước đó và hướng dẫn người yêu cầu Fix lỗi. Vào lúc 12:10 xuất hiện lỗi tại phiếu Biên bản hội chuẩn do em đã sửa từ Text Field sang dạng Droplist theo yêu cầu từ Ticket: QLYC-2994 Và em đã tiến hành sửa lại Text Field như cũ trước rồi mới tiến hành xử lí triệt để vấn đề mới. Phát hiện lỗi nghi vấn do: 1. Tài khoản em là TK Admin nên có thể in và truy cập được hầu hết các API và thiếu đuôi tong-hop? 2. Do cấu hình máy đang sử dụng HTTP thay vì HTTPS --> Browser chặn ---> Lí do chỉnh sửa hơi lâu là vì em phải lấy lại API mới cho đúng với viện và nhờ nhiều người test lại nhiều lần bằng cả tài khoản Bác sĩ, Admin và Điều dưỡng. ===> Đến 13:45 thì hoàn tất (DONE)		
32	26/09/2025 (8:00 – 17:30)	Trong ngày 26.09.2025, em đã hoàn thành các công việc của Business Analyst gồm kiểm thử, phân tích, log ticket và re-test kết quả. Những hoạt động này không chỉ giúp đảm bảo chất lượng hệ thống HIS mà còn hỗ trợ tối ưu quy trình, nâng cao hiệu quả làm việc cho đội ngũ y tế. 1. Trong ngày, em tập trung rà soát lại các Ticket còn tồn đọng, đã chuyển cho đội Dev nhưng chưa được xử lý. Em tiến hành cập nhật thông tin chi tiết, bổ sung mô tả rõ ràng hơn để Dev có thể dễ dàng nắm bắt và triển khai. Việc này giúp hạn		

Được quét bằng CamScanner

		chế tình trạng trì hoãn tiến độ, đồng thời đảm bảo mọi yêu cầu được thực hiện đúng trọng tâm. FE (QLYC-3091/NTTW) [Form phiếu] Thêm vị trí phiếu in của EMR_BA389 tại mã vị trí 00602 - In điều dưỡng --> Chỉnh sửa và bổ sung thêm 2. Em đã tiến hành kiểm thử các Ticket đang ở trạng thái "Resolve" để xác nhận tính ổn định của hệ thống sau khi Dev hoàn tất chỉnh sửa. Sau khi đảm bảo kết quả đạt yêu cầu, em chủ động cập nhật trạng thái sang "Passed Test" và chuẩn bị quy trình đẩy lên môi trường Stable, góp phần duy trì tiến độ đồng bộ giữa các giai đoạn triển khai. BE (OP - BVCR) [Lập bệnh án] Khi sửa loại bệnh án thì cập nhật luôn cả mã BA mới theo thiết lập chung --> Hoàn thành Test FE (OP - BVCR) [Lập bệnh án] Khi sửa loại bệnh án thì cập nhật luôn cả mã BA mới theo thiết lập chung --> Hoàn thành Test ==========> 2 Ticket này Test khá lâu, khá mất thời gian vì phải làm NB Test như một quy trình đầy đủ và phải kiểm tra các Module khác có liên quan đến mã BA như HSBA,.... Ban đầu khi Test thì phát hiện có chỗ chưa vừa ý và đã yêu cầu FE chỉnh sửa thêm --> Test lại và đánh Passed Test. 3. Em chủ động liên hệ, trao đổi và phối hợp trực tiếp với các Dev phụ trách để thống nhất phương án xử lý, tiến hành test và xác nhận hoàn thành hai Ticket. Quá trình phối hợp này giúp rút ngắn thời gian xử lý, đảm bảo chất lượng sản phẩm và tăng tính hiệu quả trong quy trình kiểm thử.		

Được quét bằng CamScanner

		BE (QLYC-3088/BVCR) [Nội trú] Lọc thuốc trong danh sách thuốc đã kê theo Params Tờ điều trị FE (QLYC-3088/BVCR) [Nội trú] Lọc thuốc trong danh sách thuốc đã kê ===> Chưa Hoàn thành vì đang đợi Build và Test lại 4. Em tập trung vào việc kiểm thử các Ticket nằm trong danh sách được giao, đặc biệt chú trọng đến việc tái hiện lỗi, phân tích nguyên nhân và ghi nhận chi tiết kết quả test. Những lỗi phát hiện được em log lại đầy đủ trên hệ thống để Dev có cơ sở xử lý kịp thời, giúp quy trình vận hành được trơn tru và chính xác. Đã tiến hành kiểm tra lỗi tại trường Mời bác sĩ Hội chẩn tại Biên bản Hội chẩn khi đã chọn từ Droplist nhưng không hiển thị đúng trên Biên bản khi In. ---> Không log ticket vì đã giải thích vấn đề. 5. Song song với việc kiểm thử, em tiếp tục phát hiện và ghi nhận thêm các lỗi mới phát sinh trong quá trình thao tác. Các Ticket mới được log kèm theo mô tả chi tiết, hình ảnh minh họa và bước tái hiện cụ thể để đội Dev dễ dàng tiếp nhận và xử lý. FE (OP - BVCR) [Kiểm tra hồ sơ] Bổ sung thêm Text và Cột Trạng thái tại "Thuốc, vật tư, máu, hóa chất, CPDD, suất ăn chưa tạo phiếu lĩnh, chưa duyệt lĩnh" ⇨ Test khá lâu do trên môi trường Test và môi trường Stable khác nhau và điều kiện thiết lập cũng khác nhau nên khó phân biệt trạng thái phiếu lĩnh. Ngoài những nhiệm vụ đã được giao, em chủ động xin		

Được quét bằng CamScanner

		học hỏi và tìm hiểu thêm về các báo cáo TCKT, đồng thời tham gia vào quá trình test và kiểm tra lỗi liên quan để hiểu rõ hơn về cấu trúc và luồng dữ liệu. Bên cạnh đó, em cũng dành thời gian nghiên cứu thêm về báo cáo ADR nhằm nắm vững quy trình xử lý và sẵn sàng đảm nhận các Ticket phức tạp hơn trong thời gian tới. 1. Tiến hành xin học hỏi và tìm hiểu về các báo cáo TCKT, đã tham gia vào test và kiểm tra lỗi FE (OP-BVCR) [Báo cáo TCKT] Thêm mới báo cáo TC82. BÁO CÁO TỔNG HỢP CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH --> Đã Test thử lại thì vẫn thấy lỗi BE (OP-BVCR) [Báo cáo TCKT] Thêm mới báo cáo TC82. BÁO CÁO TỔNG HỢP CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH --> Đã Test thử lại thì vẫn thấy lỗi ==> Học hỏi được cách kiểm tra nguyên nhân tại sao lại lệch nhau và sai từ bước khai báo nào. 2. Học hỏi thêm để đảm bảo hiểu rõ hơn về luồng của báo cáo ADR --> Sẵn sàng đảm nhận các Ticket khó. Trong quá trình học hỏi, em đã tìm hiểu thêm về luồng xử lý của báo cáo ADR nhằm nắm rõ cách dữ liệu được tổng hợp và hiển thị. Em chú ý đối chiếu giữa BE và FE, kiểm tra điều kiện lọc, trường dữ liệu cũng như response trả về để hiểu logic vận hành. Nhờ vậy, em có thể phát hiện nhanh các vấn đề khi kiểm thử và đưa ra nhận định chính xác hơn. Qua việc rèn luyện này, em tự tin hơn khi tiếp nhận các Ticket phức tạp và sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khó trong thời gian tới.		

Được quét bằng CamScanner